- Za pomocą obmacywania ocenia się przesuwalność, konsystencję, bolesność węzłów chłonnych.

  Jeżeli węzły chłonne są powiększone lub bolesne, bada się okolice anatomiczne, które drenują się do tych węzłów.

Rozdział 5

1. Sposób oceny ostrości wzroku jest uzależniony od wieku chorego i jego możliwości odczytania liter. W trakcie badania wykorzystuje się tablice okulistyczne Snellena z literami, znakami lub obrazkami (optotypy). Ostrość widzenia ocenia się dla każdego oka osobno, zarówno na widzenie z bliska, jak i daleka. Do badania widzenia z dali pacjent siada lub stoi w odległości 6 m od tablicy Snellena i zakrywa najpierw pierwsze oko, a następnie drugie oko. Do badania z bliska stosuje się tablice Snellena z tekstem wystandaryzowanym do bliży i ocenia ostrość widzenia każdego oka z odległości 30 cm od tablicy.
2. W ocenie źrenic uwzględnia się ich wielkość, symetrię i reakcję na światło oraz akomodację. Reakcję na światło bada się, przybliżając do źrenicy wiązkę światła punktowego (źrenica powinna się zwężać). Gdy oświetla się jedną źrenicę i obserwuje w niej reakcję zwężenia, występuje reakcja bezpośrednia na światło. Natomiast gdy oświetla się jedną ze źrenic i obserwuje równocześnie zwężenie w źrenicy sąsiedniej, to występuje reakcja skrzyżowana na światło, konsensualna. Oceniając odruch na nastawność (akomodację), obserwuje się, czy źrenice ulegają zwężeniu podczas przybliżania się przedmiotu do oczu, a rozszerzeniu podczas oddalania się tego przedmiotu. Prawidłowe źrenice są okrągłe, mają taką samą średnicę (w pomieszczeniu jasnym 2–4 mm, w pomieszczeniu zaciemnionym rozszerzają się nawet do 8 mm), są równe oraz jednakowo reagują na światło.
3. Pacjent proszony jest o patrzenie na odległy punkt przed sobą, badający stoi z boku pacjenta i kieruje wiązkę światła na badaną źrenicę od strony bliższej skroni. Obserwuje się reakcję źrenicy bezpośrednią (po stronie oświetlanej) i konsensualną (po stronie przeciwnej do oświetlanej). Badana źrenica powinna żywo zwęzić się pod wpływem światła i rozszerzyć, gdy światło zostanie wycofane. Powtórnie kieruje się światło na tę samą źrenicę, obserwując tym razem reakcję źrenicy drugiego oka. Obie źrenice powinny symetrycznie zwęzić się pod wpływem oświetlania jednej z nich. Badanie należy powtórzyć dla drugiego oka. W warunkach prawidłowych u zdecydowanej większości osób źrenice są okrągłe, o równych brzegach i tej samej wielkości, żywo reagują na światło.

4. Bada się osobno drożność jednego i drugiego nozdrza. W tym celu należy polecić pacjentowi, aby jedno z nozdrzy zamknął i starał się oddychać drugim otwartym nozdrzem. Jeśli drożność nie jest zaburzona, przepływ powietrza powinien być swobodny.
5. Badanie akumetryczne to badanie zdolności słyszenia słów z bliskiej odległości, podczas wypowiadania ich szeptem dla każdego ucha osobno. Badający staje w odległości 30–60 cm od badanego i szepcze w kierunku ucha, które nie jest przesłonięte. Test Webera ocenia przewodzenie dźwięku przez kości czaszki. Do wykonania testu należy użyć widełek stroikowych. Po wprowadzeniu ich w drganie umieszcza się ich podstawę centralnie na głowie badanego. Pacjent powinien zinterpretować słyszalność dźwięku w obu uszach. Test Rinnego ocenia przewodzenie dźwięku przez kości czaszki i kanał słuchowy. Należy podstawę drgającego stroika umieścić na wyrostku sutkowatym kości skroniowej i w momencie, kiedy pacjent nie słyszy już dźwięku, przyłożyć w okolicy kanału słuchowego. Przewodzenie dźwięku przez kość jest krótsze niż przez powietrze, co jest wynikiem prawidłowym.
6. Badanie fizykalne tarczycy obejmuje oglądanie i palpację. W czasie badania pacjent powinien się znajdować w pozycji siedzącej. Tarczycę można również zbadać, gdy pacjent leży. Szyja powinna być dobrze uwidoczniona (od dna jamy ustnej do wcięcia szyjnego mostka). Oglądanie obejmuje kontur szyi, symetrię, obecność zniekształceń. Trzeba poprosić pacjenta, aby przełknął łyk wody. Należy się wówczas skoncentrować na tym, czy gruczoł jest symetryczny i czy widoczne są zmiany guzowate. Metodą palpacyjną ustala się miejsce chrząstki tarczowatej i chrząstki pierścieniowatej, tuż pod nimi ustawia opuszki palców i skupia się na wielkości gruczołu, konsystencji, tkliwości uciskowej, obecności guzów. Należy poprosić pacjenta, aby przełknął łyk wody, i skoncentrować się na tym, co wyczuwane jest pod opuszkami palców (powinien być wyczuwany przesuwający się ku górze gruczoł).

Rozdział 6

1. Okolice grzbietowej powierzchni klatki piersiowej:
   - okolica pośrodkowa grzbietu (kręgowa) – wzdłuż przebiegu kręgosłupa,
   - parzysta okolica nadłopatkowa,
   - parzysta okolica łopatkowa – odpowiada wielkością łopatce,
   - parzysta okolica podłopatkowa.

2. Wymiar przednio-tylny klatki piersiowej jest krótszy od wymiaru bocznego.
3. U dorosłych kobiet gruczoł piersiowy umiejscowiony jest na wysokości od III do VI–VII żebra, przyśrodkowo sięga do linii przymostkowej, bocznie do linii pachowej środkowej.
4. Gruczoły piersiowe najlepiej badać w 1. tygodniu po miesiączce. Pacjentce należy się wyjaśnienie, na czym badanie będzie polegało. Trzeba zapewnić całkowitą prywatność w jego trakcie, w pokoju badań powinno być ciepło. Pacjentkę należy poprosić, aby zdjęła odzież od pasa w górę, łącznie z biustonoszem.
5. Kryteria opisu guzka gruczołu piersiowego:
   - umiejscowienie (tarcza zegara, kwadranty),
   - rozmiar,
   - kształt (okrągły, owalny),
   - konsystencja (twardy, miękki),
   - granice (gładkie, nieregularne),
   - ruchomość (ruchomy, przylega).

Rozdział 7

1. Zasady badania układu oddechowego:
   - Każde badanie przedmiotowe układu oddechowego powinno być poprzedzone badaniem podmiotowym.
   - Pacjentowi należy wyjaśnić, na czym badanie będzie polegało.
   - Pozycję pacjenta trzeba dostosować do jego stanu i badanej okolicy. Przednią powierzchnię klatki piersiowej lepiej badać w pozycji leżącej na plecach.
   - Badanie układu oddechowego należy przeprowadzić z przodu, z boku i z tyłu klatki piersiowej.
   - W badaniu stosuje się kolejno metody: oglądanie, obmacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie.
   - W pokoju badań powinno być ciepło.
   - Należy dokładnie odnotować w dokumentacji pacjenta wyniki badania.
2. U osoby dorosłej prawidłowo częstość oddechów wynosi 16–18 razy na minutę, stosunek wdechu do wydechu – 3:2. Ruchy oddechowe są regularne i rytmiczne. Oddech powinien być wykonywany bez wysiłku, niesłyszalny, bezwonny. Zachowana powinna być kolejność faz oddychania: wdech–wydech–przerwa.

3. Miejsca opukiwania klatki piersiowej:
- okolice nadobojczykowe i podobojczykowe,
- II przestrzeń międzyżebrowa prawa i lewa w linii środkowo-obojczykowej,
- IV przestrzeń międzyżebrowa na zewnątrz od linii środkowo-obojczykowej,
- VI przestrzeń międzyżebrowa w liniach pachowych środkowych,
- środek okolic nadgrzebieniowych,
- okolica międzyłopatkowa,
- okolice podłopatkowe w liniach łopatkowych.

Opukiwanie pozwala określić charakter odgłosu opukowego, który może być: jawny, nadmiernie jawny, bębenkowy i stłumiony.

4. W warunkach prawidłowych wysłuchuje się:
- szmery (dźwięki) oddechowe pęcherzykowe,
- szmery (dźwięki) oddechowe oskrzelowe.

Szmer (dźwięk) oddechowy pęcherzykowy jest słyszalny nad zdrowymi płucami podczas wdechu i na początku wydechu i jest podobny do wypowiadanej szeptem głoski „f". Wydech stanowi ⅕ fazy wdechu. Szmer (dźwięk) oddechowy oskrzelowy wysłuchuje się nad tchawicą i dużymi oskrzelami z przodu klatki piersiowej do wysokości kąta mostka z tyłu w okolicy międzyłopatkowej do wysokości czwartego kręgu piersiowego. Jest określany jako szmer występujący zarówno podczas wdechu, jak i wydechu, z przerwą pośrodku. Ma charakter chuchający, podobny do wymawianej głoski „h".

Rozdział 8

1. W celu określenia miejsca uderzenia koniuszkowego serca należy najpierw całą dłoń przyłożyć od lewej linii mostkowej aż do lewej linii pachowej przedniej, aby zorientować się w ogólnym charakterze uderzenia. Po odnalezieniu uderzenia koniuszkowego trzeba zbadać opuszkami palców wielkość, amplitudę, jego charakter, przebieg i umiejscowienie.

2. Okolica zastawki aorty znajduje się w II przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka.

3. Pierwszy ton serca (S_1) odpowiada zamknięciu zastawki dwudzielnej, następnie trójdzielnej (dwie składowe). Zbiega się ze skurczem komór i wystąpieniem tętna na tętnicy szyjnej. Zgodny jest z uderzeniem koniuszkowym.

4. Test Allena jest badaniem mającym na celu określenie prawidłowości unaczynienia tętniczego ręki, czyli drożności tętnicy promieniowej i tętnicy łokciowej, oraz tętniczego łuku dłoniowego łączącego obie tętnice.

Rozdział 9

1. Badanie fizykalne jamy brzusznej składa się z czterech etapów, wykonywanych zwykle w następującej kolejności: oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie i obmacywanie. Badanie palpacyjne może zwiększać napięcie mięśni brzucha oraz perystaltykę jelit, dlatego lepiej wykonywać je na końcu.
2. Brzuch należy osłuchiwać przed badaniem palpacyjnym, ponieważ badanie to zwiększa perystaltykę. Membranę stetoskopu przykłada się do brzucha i wysłuchuje dźwięki perystaltyczne przez około minutę w każdym kwadrancie. Trzeba ocenić częstość i charakter dźwięków jelitowych.
3. Prawidłowo wątroba zazwyczaj nie jest wyczuwalna. Jeśli jest badalna, to wyczuwa się twardy, ostry, o regularnym zarysie brzeg z gładką powierzchnią.
4. Podczas badania odbytu pacjenta, najczęściej wystarczająca dla niego jest pozycja leżąca na lewym boku z nogami zgiętymi w kolanach i biodrach, pośladki powinny być ułożone blisko krawędzi łóżka/kozetki.

Rozdział 10

1. Układ płciowy żeński składa się z narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych. Do zewnętrznych narządów zalicza się: wzgórek łonowy, wargi sromowe większe, przedsionek pochwy, wargi sromowe mniejsze, łechtaczkę, gruczoły przedsionkowe większe (gruczoły Bartholina).
2. Do oceny stopnia rozwoju cech płciowych żeńskich stosuje się skalę Tannera w zakresie rozwoju włosów łonowych i piersi.

   Rozwój włosów łonowych:
   - stadium przedpokwitaniowe (brak owłosienia),
   - delikatne owłosienie warg sromowych i dołów pachowych (pojawiają się rzadkie proste włosy wzdłuż przyśrodkowych krawędzi warg sromowych),
   - zwiększona ilość włosów na wzgórku łonowym i w dole pachowym (włosy są ciemniejsze, gęściejsze i poskręcane),
   - ilość włosów na wzgórku łonowym typowa dla kobiety dojrzałej (szczyt skierowany ku dołowi),
   - owłosienie o charakterze dojrzałym pokrywające górne części ud.

   Rozwój gruczołów piersiowych:
   - stadium przedpokwitaniowe,
   - pączkowanie piersi (widać poszerzenie otoczki i rozwój tkanki podotoczkowej),
   - powiększanie,
   - wtórny wzgórek utworzony przez otoczkę,
   - jednolita powierzchnia otoczki i pozostałej części piersi.

3. Należy wyjaśnić pacjentce cel badania i poprosić ją o rozebranie się od dolnej połowy ciała. Trzeba poinstruować, jak powinna się ułożyć do badania (na kozetce lekarskiej lub fotelu ginekologicznym). Światło powinno zostać skierowane na okolice narządów płciowych, aby zapewnić osobie badającej dobrą widoczność. Podczas badania narządów płciowych na obu rękach należy mieć rękawiczki. Pacjentka przed badaniem powinna opróżnić pęcherz moczowy.
4. Śluz szyjkowy płodny jest wodnisty i śliski o słabej lepkości, powoduje uczucie wilgotności i śliskości, jest bardzo rozciągliwy. Śluz niepłodny jest nieprzezroczysty, lepki, występuje w niewielkiej ilości, powoduje uczucie suchości w pochwie.

Rozdział 11

1. Do wewnętrznych narządów męskiego układu płciowego zalicza się: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, przewody wytryskowe, gruczoł krokowy oraz gruczoły opuszkowo-cewkowe.
2. Dojrzewanie płciowe u chłopców rozpoczyna się rok lub dwa lata później niż u dziewczynek. Pierwszym zewnętrznym objawem jest powiększenie jąder, następnie przyspieszenie wzrostu i zwiększenie masy mięśniowej. Rozwój wtórnych cech płciowych ocenia się za pomocą skali Tannera. W badaniu przedmiotowym określa się rozwój cech płciowych za pomocą oglądania oraz oceny owłosienia, prącia, jąder i moszny.
3. Przed badaniem gruczołu krokowego należy wyjaśnić pacjentowi cel badania i sposób, w jaki będzie ono wykonane. Wyjaśnić także trzeba znaczenie ułożenia do badania i poprosić o ułożenie się na boku ze zgiętymi stawami kolanowymi, aby uwypuklić pośladki. W czasie badania należy zapewnić spokój i prywatność. W pokoju badań powinno być ciepło. Badanie wykonuje się w rękawiczkach.

Rozdział 12

1. Stawy skroniowo-żuchwowe są stawami twarzoczaszki położonymi symetrycznie ku przodowi od ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego. Są najczęściej używanymi stawami ciała w związku z ich długotrwałym używaniem w czasie żucia, mowy, śpiewu, ziewania itp. Prawidłowe działanie stawu jest podstawą fizjologii narządu żucia.

   Funkcja stawów polega na wykonywaniu złożonych ruchów żuchwy:
   - wysuwania i cofania,
   - opuszczania i podnoszenia,
   - żucia.

2. Podczas badania symetrii długości kończyn dokonuje się pomiaru długości względnej i bezwzględnej. Długością względną kończyny dolnej jest odległość między kolcem biodrowym przednim górnym a szczytem kostki przyśrodkowej, długością bezwzględną jest odległość między krętarzem większym a szczytem kostki bocznej.
3. Zakres ruchu stawu biodrowego należy badać w pozycji leżącej:
   - Zgięcie stawu zawiera się w zakresie 120–140° i ograniczone jest zetknięciem przedniej powierzchni uda z klatką piersiową, wyprost (przeprost) sięga do około 30°.
   - Ruch odwiedzenia w wyproście – 45°, przywiedzenia – około 35°.
   - Ruch odwodzenia w 90-stopniowym zgięciu stawu biodrowego wynosi około 90°.
   - Ruchy rotacyjne stawu zawierają się w przedziale 35–45°.
4. Badanie ruchów stopy obejmuje ruch w stawie skokowym oraz stawach stępu i dotyczy głównie ruchów:
   - odwracania – 10°,
   - nawracania – 20°,
   - supinacji – 35°,
   - pronacji – 20°.

Rozdział 13

1. Za czucie smaku odpowiadają dwie pary nerwów czaszkowych: unerwienie czuciowe z VII nerwu czaszkowego (nerwu twarzowego) zapewnia wrażenia smakowe z ⅔ przednich języka (smak słodki i słony), a IX nerw czaszkowy (nerw językowo-gardłowy) – z ⅓ tylnej języka (smak kwaśny, gorzki). Czucie smaku nie jest badane rutynowo. Przystępując do badania, należy poprosić pacjenta o zamknięcie oczu i wysunięcie języka na brodę. Zanurzony w odpowiednim roztworze wacik przykłada się do bocznej powierzchni języka – pacjent identyfikuje smak i dopiero wtedy może wsunąć język do jamy ustnej. Po każdym roztworze smakowym i przed podaniem następnego trzeba przepłukać usta wodą.
2. W czasie badania czucia pacjent ma zamknięte oczy. Bada się jednoimienne okolice, symetrycznie po obu stronach ciała. Należy prosić pacjenta o porównanie odczuwania bodźców. Badanie czucia zaczyna się od dystalnych części ciała. W przypadku zaburzeń czucia należy ustalić obszar ich występowania zgodnie z przebiegiem dermatomu, nerwu obwodowego lub korzenia nerwu rdzeniowego. Oceniając czucie, prosi się pacjenta,

aby określił, czy czuje różnice w odbiorze bodźca w poszczególnych miejscach, aby nazwał odczuwany bodziec i określił miejsce odczuwania w stosunku do wcześniejszego bodźca. W badaniu orientacyjnym ocenia się wszystkie rodzaje czucia powierzchownego na dłoniach, przedramieniu, brzuchu, stopach i goleniach.

3. Pacjent leży wygodnie na plecach, badający delikatnie przesuwa tępy przedmiot (szpatułka) po bocznej krawędzi stopy i w poprzek podeszwy stopy, obserwując reakcję palucha i pozostałą część stopy. Prawidłowo powinno wystąpić podeszwowe zgięcie stopy i wszystkich palców – odruch Babińskiego ujemny. Wynik uznaje się za dodatni, gdy na skutek drażnienia podeszwy wystąpi grzbietowe zgięcie palucha i wachlarzowate ustawienie pozostałych palców (lub bez takiego ustawienia palców).

Rozdział 14

1. Stan ogólny noworodka ocenia się w 1., 5. i 15. minucie życia. Pierwsza ocena ma na celu uzyskanie informacji dotyczących funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i krążenia, kolejne mają określić stopień adoptowania się do środowiska zewnętrznego.
2. U noworodków węzły chłonne nie są wyczuwalne. U dzieci do 3. roku życia mogą mieć średnicę do 3 mm, a u dzieci starszych, do 12. roku życia, mogą mieć 1 cm średnicy.
3. W badaniu układu kostno-stawowego u dzieci wykorzystuje się oglądanie oraz palpację. Należy ocenić kształt oraz proporcje kończyn górnych i dolnych, a także ich tkliwość na ucisk. Następnie trzeba ocenić kręgosłup – jego kształt, ruchomość. Ocenie podlegają również stopy dziecka. W badaniu układu stawowego kluczowe znaczenie ma określenie zakresu ruchów czynnych i biernych w stawach oraz ich wygląd i symetria. U noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia ocenia się obecność objawu wyważania i przeskakiwania.
4. Odruchami fizjologicznymi znamiennymi dla okresu niemowlęcego są: odruch Moro (3.–4. miesiąc życia), ssania (około 12. miesiąca życia), chwytania i szukania (oba zanikają około 3.–4. miesiąca życia), odruch Babińskiego (około 2. roku życia).

Rozdział 15

1. Na trudności w komunikacji z pacjentem geriatrycznym największy wpływ ma:

- deficyt słuchu – odbiorczy lub przewodzeniowy,
- dysfazja – najczęściej związana z przebytym udarem, czasem cecha otępienna,
- dyzartria – choroba naczyń mózgowych, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona,
- dysfonia – choroba Parkinsona,
- otępienie (demencja) – upośledzenie wszystkich funkcji poznawczych,
- majaczenie (delirium) – upośledzenie uwagi, zaburzenia stanu czuwania i zaburzenia percepcji,
- depresja – może przypominać otępienie lub majaczenie.

2. W przypadku osób w wieku geriatrycznym w badaniu podmiotowym należy:
- uzyskać informacje dotyczące obecnych dolegliwości oraz chorób przewlekłych i przebytych,
- zebrać wywiad dotyczący leków,
- przeprowadzić wywiad rodzinny,
- zebrać wywiad socjalny i na temat codziennego funkcjonowania,
- zadać pytania szczegółowe dotyczące: upośledzenia sprawności intelektualnej, nastroju, odżywienia, jamy ustnej, bólu, funkcji zwieraczy, upośledzenia wzroku i słuchu, upadków i równowagi.

3. Od osób w wieku geriatrycznym niezbędne jest staranne zebranie wywiadu dotyczącego przyjmowania leków i uzyskanie informacji:
- jakie leki są przyjmowane przez pacjenta, z uwzględnieniem tych kupowanych bez recepty,
- jakie leki zostały wprowadzone lub odstawione w ostatnim czasie oraz czy dawkowanie od dawna przyjmowanych leków zostało zmienione,
- czy zdarza się, żeby pacjent pomijał dawkę jakiegoś leku, np. diuretyku, gdy wychodzi z domu,
- czy występują alergie i działania niepożądane leków,
- czy w domu pacjenta znajdują się zapasy niewykorzystanych leków.

Należy również ocenić:
- zdolność pacjenta do samodzielnego dawkowania leków (czy stosuje pojemnik z przegródkami, czy też opiekun pomaga przygotować leki),
- możliwości w zakresie czytania etykiet, otwierania opakowań, właściwego stosowania inhalatorów.

Jeżeli pacjent ma ze sobą swoje leki, trzeba je z nim przejrzeć, zapytać, na co są poszczególne leki, jak chory odczuwa ich działanie oraz jak często je przyjmuje.

4. Z wiekiem skóra staje się pomarszczona, luźna, traci napięcie (zmniejsza się grubość skóry właściwej i liczba naczyń w jej obrębie, następuje zwyrodnienie włókien elastycznych, dochodzi do spłaszczenia połączenia skórno-naskórkowego). Zmiany w unaczynieniu skóry sprawiają, że ta o jasnym zabarwieniu wydaje się bledsza, bardziej matowa (następuje zmiana wielkości, kształtu i zdolności barwienia się keratynocytów, spada liczba melanocytów), a skóra na grzbiecie dłoni i przedramionach – przezroczysta, delikatna, cienka i luźna. Paznokcie tracą połysk i mogą żółknąć oraz ulegać pogrubieniu; dotyczy to szczególnie paznokci u stóp. Owłosienie głowy traci pigment, co prowadzi do siwienia; siwienie włosów pachowych jest uznawane za jeden z najbardziej wiarygodnych objawów starzenia. Zmniejsza się liczba mieszków włosowych w skórze głowy. Zmniejszeniu ulega też szybkość wzrostu włosów głowy, łonowych oraz pachowych, natomiast (prawdopodobnie w związku ze zmianami hormonalnymi) u starszych kobiet czasami dochodzi do nasilenia wzrostu włosów na twarzy, a u starszych mężczyzn nasila się wzrost brwi oraz włosów w nosie i uszach.

   Badając skórę u osób w wieku geriatrycznym, należy:
   - zwrócić uwagę na fizjologiczne zmiany w procesie starzenia,
   - poszukać plamistych zmian barwnikowych, podbiegnięć krwawych i zmian wywołanych ekspozycją na promieniowanie słoneczne,
   - obejrzeć skórę podudzi w poszukiwaniu owrzodzeń,
   - u starszych przewlekle leżących pacjentów poszukać odparzeń i odleżyn,
   - zwrócić uwagę na wszelkie bolesne zmiany pęcherzykowe rozmieszczone w obrębie dermatomu,
   - ocenić owłosienie i paznokcie.

Rozdział 16

1. Schemat SOAPIER jest podobny do schematu ADPIE, gdyż opisuje taki sam obszar aktywności pielęgniarki, polegający na ocenie stanu zdrowia w wymiarze subiektywnym i obiektywnym (SO/A), analizie informacji z wyciąganiem wniosków w formie diagnozy (A/D), następnie planowaniu interwencji i ich implementacji do praktyki (PI/PI). Kolejne wspólne elementy to ocenianie stanu zdrowia pacjenta po zastosowanych działaniach (ustalenie nowej diagnozy) oraz modyfikacja postępowania (ER/E).

2. Charakterystyka pacjenta zawiera:
   - informacje subiektywne (S), tj. ból brzucha zlokalizowany wewnątrz ciała, w żołądku, ma charakter promieniujący do prawego dolnego kwadrantu, nasila się wraz z aktywnością ruchową,
   - informacje obiektywne (O), tj. czas trwania dolegliwości bólowych – 2 dni, nasilenie bólu – 8/10 w skali VAS.
3. Stosowanie klinimetrii w praktyce pielęgniarskiej pozwala na:
   - rzetelne, ze znaną dokładnością, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta,
   - przewidywanie trafnych zmian w stanie zdrowia pacjenta,
   - wnioskowanie o skuteczności terapii.
4. W celu uzyskania oceny bólu u dziecka należy:
   - wybrać skalę adekwatną do wieku i sytuacji zdrowotnej dziecka,
   - dokonać oceny stanu wskaźników z wykorzystaniem obserwacji lub wywiadu,
   - interpretować wynik pomiaru zgodnie z ustalonymi zasadami.
5. Prowadząc dokumentację pacjenta, przestrzegam następujących zasad:
   - zakresu dokumentowanych treści: informacje dotyczące rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz jego problemów pielęgnacyjnych, planowania i sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych i edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia,
   - czytelności, estetyki i chronologicznego porządku wpisów,
   - autoryzowania wpisów,
   - nie dokonuję skreśleń informacji, a każdą korektę autoryzuję,
   - sprawdzam numerowanie stron i dane identyfikacyjne pacjenta,
   - pamiętam o uzyskaniu na piśmie oświadczeń pacjenta dotyczących zgody na proponowane leczenie i wskazanie osoby mającej dostęp do informacji/ /dokumentacji,
   - używam w dokumentowaniu terminologii standaryzowanej, np. ICD-10, NANDA-I.

PYTANIA TESTOWE

1. **Które z niżej wymienionych przykładów są objawami subiektywnymi (podmiotowymi)?**
   a. Zgaga, wymioty, powiększenie wątroby, ból głowy, nudności
   b. Niesymetryczne drżenie piersiowe, zmniejszone napięcie skóry, zez
   c. Uderzenie gorąca, nudności, zgaga, ból głowy, osłabienie, ból brzucha
   d. Wzdęcie brzucha, drgawki, tachykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, nudności

2. **Który z podanych systemów jest użyteczny w ocenie stanu zagrożenia życia?**
   a. Schemat AMPLE
   b. Schemat OLDCART
   c. Skala Agar
   d. Skala Horton

3. **Jakiego rodzaju pytania użyte w wywiadzie umożliwiają pacjentowi swobodną wypowiedź dotyczącą przebiegu choroby i doznawanych przez niego objawów?**
   a. Pytania otwarte
   b. Pytania zamknięte
   c. Pytania wyjaśniające
   d. Pytania półotwarte

4. **Która linia podłużna ciała jest nieparzysta?**
   a. Linia łopatkowa
   b. Linia pachowa przednia
   c. Linia pośrodkowa tylna
   d. Linia środkowo-obojczykowa

5. **Jakie płaszczyzny wyodrębniane są w budowie ciała człowieka?**
   a. Płaszczyzna strzałkowa (pośrodkowa), płaszczyzna czołowa (wieńcowa)
   b. Płaszczyzna poprzeczna (pozioma)
   c. Płaszczyzna pośrodkowa (wieńcowa), płaszczyzna strzałkowa (pozioma)
   d. Płaszczyzna skośna

6. **Jakie podstawowe metody wykorzystywane są w badaniu przedmiotowym (fizykalnym)?**
   a. Wywiad, opukiwanie, osłuchiwanie, badanie radiologiczne
   b. Oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, palpacja
   c. Oglądanie, ważenie, badanie laboratoryjne, opukiwanie
   d. Osłuchiwanie, mierzenie, palpacja, opukiwanie

7. **Jaka powinna być prawidłowa amplituda ciśnienia tętniczego krwi?**
   a. 50–70 mmHg
   b. 20–30 mmHg
   c. 10–20 mmHg
   d. 30–50 mmHg

8. **Które z poniższych cech skóry ocenia się metodą oglądania?**
   a. Zabarwienie skóry i ciepłotę skóry
   b. Zmiany skórne, zabarwienie skóry
   c. Zmiany skórne, napięcie skóry
   d. Wilgotność skóry, ruchomość skóry

9. **Które z poniższych cech węzłów chłonnych ocenia się metodą palpacyjną?**
   a. Przesuwalność, konsystencję, bolesność
   b. Przesuwalność, umiejscowienie, tkliwość
   c. Wielkość, umiejscowienie i przesuwalność
   d. Konsystencję, wielkość i umiejscowienie

10. **Sinica obwodowa skóry występuje na skutek:**
   a. Zmniejszenia wysycenia krwi tlenem
   b. Zwiększenia wysycenia krwi tlenem
   c. Zmniejszenia perfuzji tkanek na obwodzie
   d. Zwiększenia perfuzji tkanek na obwodzie

11. Reakcja konsensualna źrenic na światło oznacza, że:

a. Podczas oświetlania jednej ze źrenic druga ulega rozszerzeniu
b. W czasie zbliżania wiązki światła do jednej ze źrenic oświetlana źrenica ulega zwężeniu
c. W czasie oświetlania jednej ze źrenic druga ulega zwężeniu
d. W czasie oświetlania źrenicy prawej lewa ulega całkowitemu rozszerzeniu

12. Próba Rinnego to badanie, które ocenia:

a. Przewodnictwo kostne
b. Przewodnictwo powietrzne
c. Ruchy błony bębenkowej
d. Jedynie przewodzenie dźwięku nad wyrostkiem sutkowym kości skroniowej

13. Testy oceniające funkcjonowanie nerwów czaszkowych zaopatrujących mięśnie zewnętrzne gałki ocznej to:

a. Ruchy gałek ocznych i ocena kierunków patrzenia w zakresie tych ruchów
b. Test Ishihary
c. Badanie ostrości wzroku
d. Ocena pola widzenia

14. Aby ocenić ujścia ślinianki przyusznej, należy:

a. Oglądać okolicę błony śluzowej dna jamy ustnej przy wędzidełku języka
b. Oglądać dziąsło przy II zębie przedtrzonowym dolnym
c. Oglądać błonę śluzową policzka na wysokości II zęba trzonowego górnego
d. Obejrzeć okolicę zębów siekacznych górnych

15. Do struktur anatomicznych przedniej ściany klatki piersiowej nie zalicza się:

a. Barków
b. Kąta mostka
c. Wyrostka kolczystego VII kręgu szyjnego
d. Kąta międzyżebrowego

16. Kąt mostka znajduje się w miejscu:

a. Pod wyrostkiem mieczykowatym mostka
b. Połączenia rękojeści mostka z jego trzonem
c. Połączenia trzonu mostka z wyrostkiem mieczykowatym
d. Połączenia mostka z żebrami

17. Które z podanych cech gruczołu piersiowego ocenisz badaniem palpacyjnym?

a. Symetrię, wielkość gruczołów piersiowych
b. Tkliwości guzków
c. Konsystencję, zwiększone ucieplenie
d. Przemieszczenie brodawki w stosunku do osi prostej sutka

18. Część oddechową układu oddechowego stanowią:

a. Gardło, krtań, tchawica
b. Oskrzelka oddechowe, przewodziki pęcherzykowe i pęcherzyki płucne
c. Jama nosowa, gardło
d. Krtań, tchawica, oskrzela i oskrzelka oddechowe

19. Jak długo trwa faza wydechu przy prawidłowym oddychaniu?

a. Około ⅕ wdechu
b. Około ½ wdechu
c. Około ¹⁄₁ wdechu
d. Około ⅛ wdechu

20. Jakie cechy układu oddechowego ocenia się badaniem palpacyjnym?

a. Ruchomości dolnych granic płuc
b. Drżenie piersiowe
c. Tor oddychania
d. Drożność nosa

21. Ruchomość dolnych granic płuc w linii łopatkowej prawidłowo u dorosłego człowieka wynosi:

a. 8 cm
b. 6 cm
c. 12 cm
d. 2 cm

22. Jakie są cechy fizjologiczne szmerów (dźwięków) oddechowych?

a. Oskrzelowy – występuje nad tchawicą i dużymi oskrzelami
b. Pęcherzykowy – zaostrzony, głośniejszy z przedłużonym wydechem
c. Oskrzelowy – występuje nad polami płucnymi
d. Pęcherzykowy – jest symetryczny i dobrze słyszalny

23. Pierwszy ton serca (S_1) jest:

a. Wynikiem zamknięcia się zastawki pnia płucnego
b. Zazwyczaj najgłośniejszy na koniuszku serca
c. Wynikiem zamknięcia się zastawek przedsionkowo-komorowych
d. Wynikiem zamknięcia się zastawki aorty

24. Uderzenie koniuszkowe jest:

a. Umiejscowione w V przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej lewej
b. Wskaźnikiem czynności prawej komory
c. Umiejscowione w V przestrzeni międzyżebrowej w linii mostkowej lewej
d. Zazwyczaj o średnicy zajmującej obszar jednej przestrzeni międzyżebrowej

25. Próba Allena jest wykonywana w celu:

a. Oceny drożności tętnicy łokciowej
b. Oceny drożności tętnic dłoni
c. Oceny drożności tętnicy promieniowej
d. Oceny drożności tętnicy ramieniowej i tętnicy promieniowej

26. W czasie badania tętna należy określić jego prawidłowe cechy, takie jak:

a. Niezgodność z czynnością serca
b. Napięcie, częstość, miarowość i wypełnienie
c. Napięcie, chybkość
d. Różnica między tętnem skurczowym i rozkurczowym

27. Jakie cechy świadczą o zróżnicowaniu tętna żylnego od tętna na tętnicy szyjnej?

a. Tętno żylne dwa szczyty w cyklu w rytmie zatokowym, a tętno tętnicze jeden szczyt w cyklu
b. Tętno tętnicze dwa szczyty w cyklu w rytmie zatokowym, a tętno żylne jeden szczyt w cyklu
c. Tętno żylne ulega zmianie po uciśnięciu brzucha, a tętno tętnicze nie ulega zmianie przy uciśnięciu brzucha
d. Tętno tętnicze ulega zmianie po uciśnięciu brzucha, a tętno żylne nie ulega zmianie przy uciśnięciu brzucha

28. Które narządy jamy brzusznej badane są w lewym górnym kwadrancie?

a. Trzon i ogon trzustki
b. Wątroba
c. Żołądek
d. Wyrostek

29. Prawidłowo nad jamą brzuszną dominuje odgłos opukowy:

a. Nadmiernie jawny
b. Przytłumiony
c. Bębenkowy
d. Jawny

30. Osłuchiwanie powierzchni brzucha przynosi korzyści w:

a. Ocenie wątroby, śledziony, zalegania mas kałowych
b. Ocenie perystaltyki jelit i wykrywania zwężeń tętnic
c. Określeniu oporu, tkliwości brzucha
d. Ocenie przepuklin, mas, zaburzeń czucia

31. Jakie cechy fizjologiczne odbytu ocenia się metodą palpacyjną?

a. Bańka odbytnicy jest pusta
b. Występują szczeliny, przetoki, zewnętrzne guzki
c. Odbytnica jest jednakowo gładka, miękka i niebolesna
d. Odbytnica jest bolesna, występują polipy, guz

32. Za pomocą jakiej skali możesz dokonać oceny żeńskiej dojrzałości płciowej?

a. Skali Normana
b. Skali dojrzałości płciowej
c. Skali Tawnera
d. Skali Tannera

33. Od czego powinno się rozpocząć badanie przedmiotowe zewnętrznych narządów płciowych?

a. Od oceny dojrzałości płciowej
b. Od badania sromu
c. Od badania przez wziernik
d. Od badania przydatków

34. Jak trzeba przygotować pacjentkę do badania wewnętrznego narządów płciowych?

a. Ułożyć na boku
b. Ułożyć na plecach
c. Ułożyć na fotelu ginekologicznym
d. Ułożyć w pozycji kolankowo-łokciowej

35. Jak rozpoznaje się położenie macicy w tyłopochyleniu?

a. Macica znajduje się prawie pod kątem prostym w stosunku do pochwy, leży ku przodowi, często towarzyszy temu zgięcie trzonu macicy ku przodowi
b. Trzon macicy z wyłączeniem szyjki jest nachylony ku tyłowi
c. Macica jest nachylona pod kątem 30° do tyłu
d. Macica jest nachylona ku tyłowi z szyjką skierowaną do przodu

36. Jakiego wziernika najczęściej używa się do badania szyjki macicy i ścian pochwy kobiety?

a. Typu Crosou
b. Typu holenderskiego
c. Typu Cusco
d. Jednołyżkowego

37. W jakim wieku kobieta zazwyczaj osiąga dojrzałość płciową?

a. 12–14 lat
b. 9–13 lat
c. 10–14 lat
d. 13–15 lat

38. Za pomocą jakiej skali można dokonać oceny męskiej dojrzałości płciowej?

a. Skali Hornera
b. Skali Tannera
c. Skali Nelsona
d. Skali rozwoju płciowego

39. Od czego powinno się rozpocząć badanie męskich narządów płciowych?

a. Od badania podmiotowego
b. Od badania gruczołu krokowego
c. Od badania moszny
d. Od oceny dojrzałości płciowej

40. Jak trzeba przygotować pacjenta do badania gruczołu krokowego?

a. Ułożyć w pozycji leżącej na plecach
b. Pacjent pozostaje w pozycji stojącej
c. Ułożyć na boku ze zgiętymi kończynami w stawach kolanowych
d. Pacjent pozostaje w pozycji stojącej z pochylonym do przodu tułowiem

41. Co to jest spodziectwo?

a. Zaburzenia w prawidłowym rozwoju moszny
b. Ciasny napletek, którego nie można zsunąć z żołędzi
c. Wrodzony brak gruczołu krokowego
d. Wrodzone przemieszczenie ujścia cewki moczowej

42. Wwarunkach prawidłowych ruch rotacjiwstawie kolanowym odbywa się:

a. Tylko w przeproście stawu kolanowego
b. W wyproście stawu kolanowego ze zgięciem grzbietowym stawu skokowego
c. W wyproście stawu z jego pełnym obciążeniem
d. W zgiętym stawie kolanowym

43. Dla osoby o mezoskelicznym typie budowy ciała charakterystyczne cechy to:

a. Przewaga części mózgowej czaszki nad twarzą, zachowane proporcje ciała ze słabo rozwiniętym układem mięśniowym
b. Jest wysoka, szczupła, o słabo rozwiniętej tkance tłuszczowej i mięśniowej, z zapadniętym brzuchem i klatką piersiową
c. Ma kończyny o średniej długości
d. Podskórna tkanka tłuszczowa jest dobrze rozwinięta, mięśnie są słabo rozwinięte, ma wydatny brzuch, słabo rozwiniętą klatkę piersiową, stosunkowo krótkie kończyny

44. Terminem „kifoza" określa się:

a. Fizjologiczne wygięcie kręgosłupa ku przodowi w odcinku szyjnym i lędźwiowym
b. Fizjologiczne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym
c. Wygięcie kręgosłupa ku bokowi w okresie dojrzewania
d. Wygięcie kręgosłupa lędźwiowego ku przodowi związane z nadmiernym przodopochyleniem miednicy

45. Określenie anatomiczne „ręka" dotyczy:

a. Części kończyny górnej obwodowo od nadgarstka
b. Całej kończyny górnej od barku do palców
c. Części kończyny górnej od łokcia do nadgarstka bez dłoni
d. Kończyny górnej bez stawu barkowego

46. Co określa się słowem „lordosis" w naturalnych krzywiznach kręgosłupa?

a. Tyłowygięcie lędźwiowe
b. Tyłowygięcie krzyżowo-guziczne
c. Przodopochylenie miednicy
d. Przodowygięcie szyjne

47. Na czym polega pomiar Schobera?

a. Na pomiarze długości kończyn górnych
b. Na pomiarze długości kończyn dolnych
c. Na pomiarze oddalenia wyrostków kolczystych
d. Na pomiarze siły mięśni

48. W jakiej pozycji powinno się badać stawy biodrowe?

a. Leżącej na plecach
b. Stojącej
c. Leżącej na brzuchu
d. Kolankowo-łokciowej

49. Test MMSE służy do oceny:

a. Wybranych elementów stanu psychicznego pacjenta
b. Stanu fizycznego pacjenta
c. Umiejętności funkcjonalnych
d. Wydolności opiekuńczej rodziny pacjenta

50. Obecność zaników w obrębie mięśni żucia po jednej stronie twarzy może świadczyć o uszkodzeniu:

a. VII nerwu czaszkowego (nerwu twarzowego)
b. V nerwu czaszkowego (nerwu trójdzielnego)
c. III nerwu czaszkowego (nerwu okoruchowego)
d. XII nerwu czaszkowego (językowo-gardłowego)

51. Pacjent jest w stanie przesunąć niedowładną kończyną górną po podłożu, nie potrafi unieść jej do góry. W skali Lovetta (według MRC) siłę mięśniową tej kończyny ocenia się na:

a. 1 pkt
b. 2 pkt
c. 3 pkt
d. 4 pkt

52. Odruch Babińskiego bada się:

a. Drażniąc boczną krawędź stopy poniżej kostki bocznej
b. Pocierając kciukiem i zgiętym palcem wskazującym przednio-przyśrodkową powierzchnię kości piszczelowej w kierunku stopy
c. Energicznie uderzając własnymi palcami lub młoteczkiem neurologicznym w opuszki palców stopy pacjenta
d. Drażniąc przedmiotem stopę po jej bocznej krawędzi i w poprzek poduszki palców

53. Objawem oponowym nie jest:

a. Sztywność karku
b. Objaw Kerniga
c. Objaw Babińskiego
d. Objaw Brudzińskiego

54. Chód na szerokiej podstawie u dziecka obserwuje się do:

a. 2. roku życia
b. 3. roku życia
c. 4. roku życia
d. 5. roku życia

55. Fizjologiczne zmniejszenie masy ciała u noworodka następuje w:

a. 5. dobie życia
b. 3.–4. dobie życia
c. 2. dobie życia
d. Po około 7 dniach od narodzin

56. Objaw wyważania nazywa się objawem:

a. Ortolaniego
b. Fishera
c. Barlowa
d. Brudzińskiego

57. Objaw „piłeczki pingpongowej" obserwuje się w:

a. Wrodzonej łamliwości kości
b. Krzywicy
c. Sytuacji, kiedy nie jest jeszcze zarośnięte ciemiączko tylne
d. Odwodnieniu

58. Prawidłowa liczba oddechów u rocznego dziecka wynosi:

a. 30 oddechów/minutę
b. 24 oddechy/minutę
c. 35 oddechów/minutę
d. 20 oddechów/minutę

59. Prawidłowa czynność serca u noworodka waha się w granicach:

a. 140–160/minutę
b. 50–90/minutę
c. 100–180/minutę
d. 80–100/minutę

60. Odruch podeszwowy Babińskiego jest fizjologiczny u dziecka do:

a. 1. miesiąca życia
b. 2. roku życia
c. 6.–8. miesiąca życia
d. 1. roku życia

61. Fizjologiczny odruch chwytania zanika:

a. W 3.–4. miesiącu życia
b. Około 1. roku życia
c. W 2. roku życia
d. Zaraz po urodzeniu

62. Miejsce uderzenia koniuszkowego u dziecka w wieku do 4.–5. roku życia znajduje się w:

a. V przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej przedniej
b. IV przestrzeni międzyżebrowej w okolicy linii środkowo-obojczykowej lewej
c. V przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej lewej
d. III przestrzeni międzyżebrowej w linii sutkowej lewej

63. W wyniku starzenia się organizmu u pacjenta w wieku geriatrycznym błona bębenkowa:

a. Ulega pogrubieniu, często staje się matowa i biała
b. Staje się cienka i różowa
c. Zanika
d. Ulega pogrubieniu, staje się lśniąca i różowa

64. W trakcie wywiadu z pacjentem w wieku geriatrycznym:

a. Nie zadaje się pytań otwartych
b. Pacjent powinien mieć założone okulary, aparat słuchowy i protezy zębowe, jeżeli ich na co dzień używa
c. Pacjent powinien zdjąć okulary, aparat słuchowy i protezy zębowe
d. W pomieszczeniu powinno być przyciemnione światło, które pomaga kompensować zmiany w soczewkach i lepiej widzieć

65. Badanie ortostatycznego spadku ciśnienia polega na zmierzeniu ciśnienia tętniczego krwi:

a. Na ramieniu i kostce
b. Przed wysiłkiem i po nim
c. U pacjenta w pozycji stojącej, a następnie w ciągu 30 minut w pozycji leżącej
d. U pacjenta w pozycji leżącej, a następnie w ciągu 3 minut w pozycji stojącej

66. Jaką część opisu stanu zdrowia pacjenta według schematu SOAP wypełnia informacja „zmniejszenie energii/osłabienie"?

a. Informacje subiektywne (S)
b. Informacje obiektywne (O)
c. Ocena stanu zdrowia (A)
d. Planowanie opieki (P)

67. Która część opisu stanu zdrowia pacjenta według schematu SOAP będzie zawierać następujące oświadczenie: „Pacjent może wykonywać ćwiczenia w domu co drugi dzień w następnym tygodniu"?

a. Informacje subiektywne (S)
b. Informacje obiektywne (O)
c. Ocena stanu zdrowia (A)
d. Planowanie opieki (P)

68. W którym elemencie struktury SOAP i jej dokumentowania zastosujesz pielęgniarską terminologię standaryzowaną NANDA-I?

a. Informacje subiektywne (S)
b. Informacje obiektywne (O)
c. Ocena stanu zdrowia (A)
d. Planowanie opieki (P)

69. Na czym polega klinimetria?

a. Na stosowaniu obiektywnego pomiaru i oceny danych klinicznych
b. Na stosowaniu subiektywnej oceny stanu pacjenta
c. Na stosowaniu obiektywnego pomiaru i oceny subiektywnej stanu pacjenta
d. Na stosowaniu testów w teorii i praktyce

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ TESTOWYCH

TABELA ODPOWIEDZI DO PYTAŃ TESTOWYCH

1	c	19	a	37	a	55	b
2	a	20	b, d	38	b	56	c
3	a	21	b	39	a	57	b
4	c	22	a, d	40	c	58	b
5	a, b	23	b, c	41	d	59	c
6	b	24	a, d	42	d	60	b
7	d	25	a, c	43	c	61	a
8	b	26	b	44	b	62	b
9	a	27	a, c	45	a	63	a
10	c	28	a, c	46	d	64	b
11	b, c	29	c	47	c	65	d
12	a, b	30	b	48	a	66	a
13	a	31	a, c	49	a	67	d
14	c	32	d	50	b	68	c
15	c	33	a	51	b	69	a
16	b	34	c	52	d		
17	b, c	35	d	53	c		
18	b	36	c	54	a		

SKOROWIDZ

ADPIE 350
Agnozja dotykowa 268
Agrafia 241
Agresja, ryzyko 244
Akomodacja oka 249
Alkohol, uzależnienie 25
AMPLE 27
Anatomia topograficzna, podstawy 35
Aorta brzuszna, badanie palpacyjne 159
– osłuchiwanie 155
Aparaty do mierzenia ciśnienia krwi tętniczego 50
APN 352
Apraksja 241

Badanie, akomodacji źrenic 77
– aorty brzusznej palpacyjne 159
– barku 213
– brodawki sutkowej palpacyjne 111
– brzucha 151
– – palpacyjne 157
– – przedmiotowe 152
– chodu 270
– cytologiczne, pobieranie materiału 176, 178
– czucia 262
– – bólu 267
– – dotyku 267
– – – u osób w wieku geriatrycznym 323
– – dyskryminacji dwóch punktów 268
– – głębokiego 266
– – powierzchownego 267
– – temperatury 267
– – ułożenia 267
– – wibracji 266
– dna oka 80
– drożności nosa 116
Badanie, drżenia, głosowego 119
– – piersiowego 119
– dziecka 285
– – podmiotowe 283
– – przedmiotowe 284
– fizykalne 35
– funkcji nerwu, trójdzielnego, czuciowych 250
– – – ruchowych 249
– – twarzowego ruchowych i czuciowych 251
– gardła 90
– – dziecka 293, 296
– głowy 73, 74
– – dziecka 292
– – u osób w wieku geriatrycznym 320
– gruczołu(ów), Bartholina palpacyjne 172
– – krokowego, palpacyjne 189, 190
– – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – piersiowych 99, 106
– – – palpacyjne 109
– – – u mężczyzn 111
– – – u osób w wieku geriatrycznym 324
– – tarczowego 95, 97
– – – dokumentowane wyników 97
– jamy, brzusznej, dziecka 304
– – – u osób w wieku geriatrycznym 326
– – ustnej 90
– – – dziecka 293, 296
– – – u osób w wieku geriatrycznym 316
– jądra 187
– kciuka 218
– klatki piersiowej 99
– – palpacyjne 116
– – przedmiotowe 115
Badanie, klatki piersiowej, u osób w wieku geriatrycznym 324
– kończyn(y), dolnej(ych) 223, 261
– – górnej(ych) 213, 260
– koordynacji ruchowej 270, 271
– krążenia włośniczkowego 143
– kręgosłupa 207
– macicy dwuręczne 175
– miednicy 221
– mięśni 205
– – żucia palpacyjne 249
– moszny 187
– mowy 253
– nadgarstka 217
– najądrza 188
– napięcia mięśniowego 259
– narządu(ów), moczowo-płciowych u dziecka 306
– – płciowych, męskich 183
– – – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – – żeńskich 167, 173
– – – – u osób w wieku geriatrycznym 326
– – – – wewnętrznych palpacyjne 175
– – – – wewnętrznych z użyciem wziernika pochwowego 176
– – równowagi 252
– – słuchu, u dziecka 295
– – – u osób w wieku geriatrycznym 317, 323
– – węchu i zatok przynosowych u dziecka 294
– – wzroku 75
– – – u dziecka 294
– – – u osób w wieku geriatrycznym 317, 321
– – zmysłów u dziecka 293

Badanie, nerwów czaszkowych 247
– – u dzieci 309
– neurologiczne, elementy 237
– nosa 86
– objawu(ów), chełbotania 188
– – oponowych 280
– obrzęku 59
– obrzmienia moszny 188, 189
– odbytniczo-pochwowe palpacyjne 175
– odbytu 163
– odruchu(ów) 272
– – Babińskiego 278, 279
– – brzusznych 278
– – gardłowego 253
– – głębokich 274
– – na zbieżność i nastawienie 249
– – podeszwowego 278, 279
– – rogówkowego 250, 251
– okolicy, okołoodbytniczej palpacyjne 189, 194
– – pachowej u osób w wieku geriatrycznym 324
– – pachwinowej 187
– – przedsercowej 132
– osób w wieku geriatrycznym, podmiotowe 311, 312
– – przedmiotowe 311, 317
– ostrości widzenia 78
– palców 219
– palucha 229
– paznokci 63
– płuc u osób w wieku geriatrycznym 324
– podmiotowe 23
– – sposób badania 26
– – wyniki 282
– – – analiza na potrzeby oceny stanu zdrowia 352
– – – ocena na ich podstawie stanu zdrowia pacjenta 331
– – zasady przeprowadzania 23
Badanie, pola widzenia 78, 79
– położenia tchawicy 117
– powrózka nasiennego 187
– prącia 187
– przedmiotowe 35
– – metody 40
– – ogólne 44
– – wyniki 282
– – – analiza na potrzeby oceny stanu zdrowia 352
– – – ocena na ich podstawie stanu zdrowia pacjenta 331
– – zasady ogólne 40, 43
– przedramienia 216
– przez odbyt palpacyjne 164
– przydatków skóry 57
– – u dziecka 287
– reakcji źrenic na światło 77
– ręki 218
– rozszerzalności klatki piersiowej 118
– równowagi 270
– ruchomości, granic dolnych płuc 120
– – języka 254
– ruchów, czynnych 260
– – gałek ocznych 79, 248
– serca 130
– siły mięśniowej 254, 260, 261
– skóry 57
– – dziecka 287
– – palpacyjne 59
– – u osób w wieku geriatrycznym 320
– słuchu 84
– stawu, biodrowego 223
– – kolanowego 226
– – łokciowego 216
– – skokowego 227
– – skroniowo-żuchwowego 206
– stopy 227
– symetrii długości kończyn 201
– sztywności karku 280
– szyi 73, 94
– – dziecka 292
Badanie, szyi, u osób w wieku geriatrycznym 320
– ściany przedniej macicy palpacyjne 176
– ślinianki przyusznej 94
– tarczycy dziecka 297
– tchawicy 98
– – palpacyjne 118
– tętna, tętniczego137
– – – na tętnicy, grzbietowej stopy 139, 142
– – – piszczelowej 139
– – – podkolanowej 139, 141
– – – promieniowej 139, 140
– – – ramiennej 139, 141
– – – szyjnej 139, 141
– – – udowej 139, 141
– – u osób w wieku geriatrycznym 326
– – żylnego 143
– ucha 83
– – zewnętrznego 84
– uderzenia koniuszkowego 132
– ujścia cewki moczowej palpacyjne 174
– układu, kostno-stawowego u dziecka 290
– – krążenia 129
– – – u dziecka 300
– – mięśniowo-szkieletowego 197, 205
– – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – narządu ruchu 197
– – nerwowego, u dziecka 307
– – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – oddechowego 113
– – – u dziecka 297
– – ruchu 257
– – sercowo-naczyniowego u osób w wieku geriatrycznym 324
– – żylnego 143
– ukrwienia ręki tętniczego 142
– ustawienia gałek ocznych 248

Badanie, warg sromowych palpacyjne 172
– wątroby palpacyjne 158, 159, 162
– wejścia do pochwy 174
– węzłów chłonnych 57, 66
– – głowy 69
– – nadobojczykowych 70
– – pachowych 111
– – pachwinowych 70
– – – palpacyjne 188
– – palpacyjne 69
– – podkolanowych 71
– – ramienia 70
– – szyi 69
– – u dziecka 289
– widzenia, barw 78
– – z bliska 78
– – z dali 78
– włosów 62
– zatok przynosowych 86, 88
– zborności 270
– zdolności połykania 253
Bark, badanie 213
– zakres ruchu w stawach 202
Bezdech 125
Bielactwo nabyte 61
Blizna(y) 61
– po operacjach jamy brzusznej, umiejscowienie 162
BMI 47
Bodźce czuciowe, interpretacja 268
Ból, badanie czucia 267
– u osób w wieku geriatrycznym 316
Bransolety krzywicze 291
Brodawka sutkowa 106
– badanie palpacyjne 111
Bruzdy Harrisona 298
Brzuch, badanie 151
– – dokumentowanie wyników 160
– – palpacyjne 157
– – – głębokie 158
– – – powierzchniowe 158
– – przedmiotowe 152
– opukiwanie, powierzchni 157
Brzuch, opukiwanie, techniki 156
– osłuchiwanie 155
– ściana przednia, kwadranty 151
– – naczynia tętnicze 154
– – okolice 151

Cewka moczowa, zapalenie 192
Choroba(y), gardła infekcyjne, objawy 93
– przebyte 30
– – u osób w wieku geriatrycznym 314
– przewlekłe u osób w wieku geriatrycznym 314
– reumatyczna 232
Chód, ocena 44, 270
– patologia 199
Chybkość tętna 139
Ciało, budowa 45
– jamy 39, 40
– kierunki 35, 36
– linie 37, 38
– niemowlęcia, ułożenie nieprawidłowe 310
– płaszczyzny 37
– postawa pionowa 286
– pozycja 44
– proporcje 45, 200
– ruchy 286
– rzęskowe 76
– typ budowy według, Kretschmera 199
– – Menouvriera 199
– – Sigmonda 199
Ciąża, rozpoznanie 174
Ciemiączka, zarastanie przedwczesne/opóźnione 293
Ciepłota skóry 59
Ciśnienie krwi, tętnicze 48, 148
– – aparaty do pomiaru 50
– – pomiar 50
– – – błędy najczęstsze 53
– – – dokumentowanie wyników badań 54
– – – etapy 53
– – u dziecka 301, 304
Ciśnienie krwi, tętnicze, u osób w wieku geriatrycznym 319
– żylne 149
– – pomiar 145
CTK 50
Cykl miesiączkowy 169
Cytologia, konwencjonalna metodą Papanicolau 176
– płynna 177
Czaszka, zmiany w budowie 75
Częstoskurcz 303
Częstość, oddechów 48
– tętna 137
Czucie, badanie 262
– – dokumentowanie wyników 270
– bólu, badanie 267
– dotyku, badanie 267
– – – u osób w wieku geriatrycznym 323
– dyskryminacji dwóch punktów, badanie 268
– głębokie, badanie 267
– powierzchowne, badanie 267
– temperatury, badanie 267
– ułożenia, badanie 267
– wibracji, badanie 266
Czynniki kulturowo-społeczne 17
Czynność(ci), oddechowa, ocena 113
– serca 147
– wyuczone, wykonywanie 241

Dane ogólne 28
Deficyty neurologiczne 25
Dermatomy 264
Dermoleksja 269
Diafanoskopia 188
Długość, głowy, pomiar 45
– klatki piersiowej 103
– kończyn(y), czynnościowa, określanie 201
– – dolnej, pomiar 45
– – – względna, pomiar 201
– – górnej, pomiar 45, 46
– tułowia, pomiar 45

Dno, miednicy mniejszej, zwiotczenie 180
– oka, badanie 80
– – – dokumentowanie wyników 83
Dojrzałość płciowa, ocena 170, 185
– – według skali Tannera 186, 187
Dokumentacja, medyczna 331
– przykładowa 351
Dokumentowanie, opieki pielęgniarskiej 332
– wyników badania(ń) 44, 332
– – brzucha 160
– – ciśnienia krwi tętniczego 54
– – czucia 270
– – dziecka 286
– – gardła 93
– – – dziecka 296
– – głowy dziecka 293
– – gruczołu(ów), piersiowych 112
– – – tarczowego 97
– – jamy, brzusznej u dziecka 305
– – – ustnej 93, 94
– – – – u dziecka 296
– – koordynacji ruchowej 272
– – masy ciała 47
– – narządu(ów), moczowo-płciowych u dziecka 307
– – – płciowych, męskich 191
– – – – żeńskich 179
– – – słuchu u dziecka 295
– – – węchu i zatok przynosowych u dziecka 295
– – – wzroku 82, 83
– – nerwów czaszkowych 255
– – nosa 89
– – objawów oponowych 281
– – odbytu 165
– – oddechu 49
Dokumentowanie, wyników badania(ń), odruchów 279, 280
– – paznokci 64, 65
– – równowagi 272
– – serca 146
– – skóry 60
– – – i jej przydatków u dziecka 288
– – stanu psychicznego 245
– – temperatury ciała 55
– – tętna 50
– – ucha 86
– – układu, kostno-stawowego u dziecka 291
– – – krążenia u dziecka 302
– – – narządu ruchu 230
– – – nerwowego u dziecka 309
– – – oddechowego 124
– – – – u dziecka 298
– – – ruchu 262
– – węzłów chłonnych 71
– – – u dziecka 292
– – włosów 62, 63
– – zatok przynosowych 89
Dolegliwości, ogólne 30
– u osób w wieku geriatrycznym 314
– ze strony narządów/ /układów 30
Dotyk, badanie czucia 267
Droga(i), czuciowe 262
– korowo-rdzeniowa, boczna 257
– – przednia 257
– oddechowe 113
– – dolne 113
– – górne 113
– piramidowa 237, 257
– rdzeniowo-móżdżkowa, przednia 263
– – tylna 263
– rdzeniowo-wzgórzowa, boczna 262
– – przednia 263
Drożność nosa 126
– badanie 116
Drżenie, głosowe 119
– mięśniowe 259
– pęczkowe 259
– piersiowe 126, 119
Działania arytmetyczne 243
Dziąsła 296
– stan zapalny 94
Dziecko, badanie 283
– – dokumentowanie wyników 286
– – gardła 293, 295
– – głowy 292
– – jamy, brzusznej 304
– – – ustnej 293, 296
– – narządu(ów), moczowo-płciowych 306
– – – słuchu 295
– – – węchu i zatok przynosowych 294
– – – wzroku 294
– – – zmysłów 293
– – nerwów czaszkowych 309
– – podmiotowe 283
– – przedmiotowe 284
– – skóry i jej przydatków 287
– – szyi 292
– – tarczycy 297
– – układu, kostno-stawowego 290
– – – krążenia 300
– – – nerwowego 307
– – – oddechowego 297
– – węzłów chłonnych 289
– ciśnienie krwi tętnicze 301, 304
– częstość pracy serca 303
– liczba oddechów 298, 299
– ocena stanu zdrowia 337
– – ogólnego 284
– osłuchiwanie serca 301
– pomiar obwodu głowy 292
– tętno 301
– ułożenie ciała nieprawidłowe 310
– zdrowe 286
– – ułożenie 286
Dźwięk oddechowy, oskrzelowy 122, 127
– pęcherzykowy 122, 127

Elastyczność skóry 59
Etnos 19

Faza, rozkurczu 132
– skurczu 131
– wdechu 121
– wydechu 121
Funkcje psychiczne 239
Furczenia 127

Gadatliwość 25
Gałka(i) oczna(e) 75
– badanie, ruchów 79, 248
– – ustawienia 248
– kierunki ruchów 80
– ruchomość 294
Garb 105
– sercowy 132, 300, 302
Gardło, badanie 90
– – dokumentowanie wyników 93
– – u dziecka 293, 296
– – – dokumentowanie wyników 296
– objawy chorób infekcyjnych 93
– zapalenie, ostre 93
– – przewlekłe 93
GDS 347
Głos, przewodzenie 127
Głowa, badanie 73, 74
– – u dziecka 292
– – – dokumentowanie wyników 293
– – u osób w wieku geriatrycznym 320
– okolice topograficzne 73
– pomiar, długości 45
– – obwodu u dziecka 292
– – wysokości 45
– proporcje 286
– topografia 74
Głuchota typu, odbiorczego 86
– przewodzeniowego 86
Goleń, pomiar obwodu 200
Grafestezja 269
Grubość fałdu skórno-tłuszczowego, pomiar 46, 47
Gruczoł(y), Bartholina, badanie palpacyjne 172
– – zmiany 180
– krokowy 184
Gruczoł, krokowy, badanie 189
– – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – przerost łagodny 194
– – rak 194
– – zapalenie ostre 194
– łojowe 57
– opuszkowo-cewkowe 185
– piersiowy(e), badanie 99, 106
– – – dokumentowanie wyników 112
– – – palpacyjne 109
– – – pozycje 109
– – – techniki 109
– – – u mężczyzn 111
– – – u osób w wieku geriatrycznym 324
– – naczynia chłonne 107
– – oglądanie 108
– – stopień rozwoju według skali Tannera 171, 172
– – struktura 106
– – topografia 108
– – umiejscowienie 106
– potowe 57
– sutkowy patrz Gruczoł piersiowy
– tarczowy, badanie 95, 97
– – – dokumentowanie wyników 97
– – oglądanie 97
Grupa etniczna 19
Grzybica jamy ustnej 94
Guz jądra 193
Guzki Heberdena 233

Hipotensja 303

IER 352
Inteligencja 243
Interpretacja 23

Jajniki 168
Jajowody 168
Jama(y), brzuszna, badanie, u dziecka 304
– – – – dokumentowanie wyników 305
– – – u osób w wieku geriatrycznym 326
Jama(y), brzuszna, położenie narządów 152
– – umiejscowienie blizn po operacjach 162
– ciała 39, 40
– nosowa 86
– ustna, badanie 90
– – – dokumentowanie wyników 93, 94
– – – u dziecka 293, 296
– – – – dokumentowanie wyników 296
– – – u osób w wieku geriatrycznym 316
– – budowa 91
– – grzybica 94
– – właściwa 90
– – zmiany zapalne 94
Jądro(a) 183
– badanie 187
– brak 307
– guz 193
– małe 193
– nerwów czaszkowych, umiejscowienie 258
– niezstąpienie 193
– skręt 193
– zanik 193
– zapalenie ostre 193
Języczek, oglądanie 253
Język 44, 296
– ocena ruchomości 254
– oglądanie 254
– zmiany 94

Kanał odbytu 163
Kandydoza moszny 193
Kciuk, badanie 218
– zakres ruchu 203, 219
Kierunki ciała 35, 36
Kifoza 105, 231
– nadmierna 105, 207
Kiła drugorzędowa 179
Klasa społeczna 18
Klasyfikacja siły mięśniowej 261
Klatka piersiowa 287
– badanie 99
– – palpacyjne 116
– – przedmiotowe 115
– – u osób w wieku geriatrycznym 324

Klatka piersiowa, beczkowata 123
– długość 103
– kształt 102, 300
– – nieprawidłowy 123
– kurza 123
– lejkowata 123
– oglądanie 115
– określanie wymiarów 115
– opukiwanie 119
– rozszerzalność 118, 126
– struktury anatomiczne 99
– symetria 102, 115, 116, 124
– ściana, boczna, linie topograficzne 102
– – grzbietowa, okolice topograficzne 100
– – przednia 103
– – – linie topograficzne 101, 102
– – – okolice topograficzne 99, 100
– – – struktury anatomiczne 101
– – tylna 104
– – – linie topograficzne 102
– – – struktury anatomiczne 101
– typ budowy, leptosomiczny 104
– – normosteniczny 104
– – pykniczny 104
– zmieniona krzywiczo 298
Klinimetria 336
Kłykciny, kończyste 179, 192
– płaskie 179
„Koci mruk" 302
Kolor skóry 58
Komora(y) serca 131
– lewa, powiększenie 302
– przerost 302
Komórka jajowa 168
Komunikacja 19
– werbalna, zaburzenia 282
Komunikowanie się z pacjentem, trudności 312
Konfrontacja 23
Kontakty międzyludzkie 244
Kończyna(y), badanie symetrii długości 201
– długość czynnościowa, określanie 201
– dolna(e), badanie 223, 261
– – obwody 200
– – pomiar długości 45
– – – względnej 201
– górna(e), badanie 213, 260
– – obwody 200
– – pomiar długości 45, 46
– proporcje 288
Koordynacja ruchowa, badanie 270, 271
– – dokumentowanie wyników 272
Kora mózgu 237
Korzystanie z toalety 282
Kość promieniowa, złamanie 232
Koślawość, miara 226
Krążenie, tętnicze, ocena 137
– włośniczkowe, ocena 143
– żylne, ocena 143
Kręgosłup, badanie 207
– – odcinka, piersiowo-lędźwiowego 209
– – – szyjnego 208
– krzywizny 105, 207, 212
– kształt 212
– ograniczenie ruchomości 231
– piersiowo-lędźwiowy, zakres ruchu w stawach 202, 209, 210, 211, 212
– szyjny, zakres ruchu w stawach 202, 208, 209, 212
– zmiany w jego obrębie 231
– zniekształcenia 105
Krosta 61
Krzywica 295
Krzywizny kręgosłupa 105, 207, 212
Kultura 15
Kwadranty ściany brzucha przedniej 151
Kwestionariusz bólu McGill 340, 343

Leki, przyjmowane 28
– – regularność 29
– uczulenia 29
– wywiad u osób w wieku geriatrycznym 314
Lęk 25
Limfadenopatia 71
Linie, ciała 37, 38
– topograficzne klatki piersiowej 101, 102
Lordoza 105, 231
– nadmierna 105, 207, 291
LWS 341

Łechtaczka, oglądanie 172
– przerost 307
Łokieć, golfisty 232
– tenisisty 232
– zakres ruchu w stawach 202
Łuk odruchowy 272
– odruchu kolanowego 273
Łuska 61
Łysienie 63

Macica 168
– badanie dwuręczne 175
– położenie 180
– ściana przednia, badanie palpacyjne 176
– w przodopochyleniu 180
– w tyłopochyleniu 180
– w tyłozgięciu 180
Małogłowie 293
Masa ciała, pomiar 46
– – dokumentowanie wyników badań 47
– – u dziecka 285, 287
– wskaźnik 47
Menopauza 169
Metoda Korotkowa 50
Miarowość, serca 147
– tętna 138
Miednica, badanie 221
– ocena ustawienia 222
– przodopochylenie nadmierne 233

Miednica, ustawienie skośne 233
– zmiany 180, 233
Mięsień(śnie), badanie 205
– czworoboczny, ocena siły 254
– dna miednicy, osłabienie 180
– gałki ocznej 75
– języka, ocena siły 254
– mimiczne 251
– mostkowo-obojczykowo-sutkowy, ocena siły 254
– napięcie 309
– sercowy, zapalenie 303
– żucia, badanie palpacyjne 249
– – oglądanie 249
– zwieracz odbytu, wewnętrzny 163
– – zewnętrzny 163
Mięsko cewki moczowej 180
Mięśniak macicy 180
Migdałki podniebienne 296
Milczenie 25
Moszna, badanie 187
– kandydoza 193
– zmiany 193
Mowa 44, 240, 253
Mózg 237
– funkcje 238
Mózgoczaszka 73
Mózgowie 237
Móżdżek 270
– funkcje 238
MPQ 342
Myślenie 243
– abstrakcyjne 243
– konkretne 244
– pojęciowe 243
– sensoryczno-motoryczne 243

Naczynia, chłonne 129
– – głowy i szyi 66
– – gruczołu piersiowego 107
– – kończyn dolnych 67
– – ręki i ramienia 67
– krwionośne 129
– ściany brzucha przedniej tętnicze 154
Naczynia, wielkie, położenie w klatce piersiowej 130
Naczyniówka 76
Nadciśnienie tętnicze 303
Nadgarstek, badanie 217
– zakres ruchu 203, 218
– zmiany 232
Najądrze 183
– badanie 188
– torbiel 193
– zapalenie, gruźlicze 193
– – ostre 193
NANDA 352
Napięcie, mięśniowe 309
– – badanie 259
– – osłabienie 260
– skóry 59
– tętna 138
Napletek, zadzierzgnięcie 191
– zapalenie 191
Narkotyki, uzależnienie 25
Narząd(y), dolegliwości z ich strony 30
– jamy brzusznej, położenie 152
– łzowy 75
– moczowo-płciowe, badanie u dziecka 306
– – – dokumentowanie wyników 307
– płciowe, męskie 185
– – – badanie 183
– – – – dokumentowanie wyników 191
– – – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – – zewnętrzne, zmiany 194
– – opryszczka 191
– – żeńskie, badanie 165, 173
– – – – dokumentowanie wyników 179
– – – – u osób w wieku geriatrycznym 326
– – – infekcja grzybicza 179
– – – opryszczka 179
– – – wewnętrzne 167, 169
– – – – badanie palpacyjne 175
Narząd(y), płciowe, opryszczka, badanie z użyciem wziernika pochwowego 176
– – – zewnętrzne 167, 170
– równowagi, badanie 252
– słuchu, badanie, u dziecka 295
– – – – dokumentowanie wyników 295
– – – u osób w wieku geriatrycznym 317, 323
– węchu, badanie u dziecka 294
– – – dokumentowanie wyników 295
– wzroku, badanie 75
– – – dokumentowanie wyników 82
– – – u dziecka 294
– – – u osób w wieku geriatrycznym 317, 321
– – zmiany chorobowe 82
– zmysłów, badanie u dziecka 293
– – objawy dysfunkcji najczęstsze 31
Nasieniowody 184
Naskórek 57
Nastrój 44, 244
– u osób w wieku geriatrycznym 316
Nawrót kapilarny 143
Nerw(y), bloczkowy 80, 248, 255
– błędny 252, 253, 256
– czaszkowy(e), I 247, 255
– – II 248, 255
– – III 248, 255
– – IV 248, 255
– – V 249, 255
– – VI 248, 255
– – VII 251, 256
– – VIII 252, 256
– – IX 252, 256
– – X 252, 256
– – XI 253, 257
– – XII 254, 257
– – badanie u dzieci 309
– – dokumentowanie wyników badań 255
– – ocena 247

Nerw(y), czaszkowy, umiejscowienie jąder 258
– dodatkowy 253, 257
– językowo-gardłowy 252, 256
– kulszowy, neuralgia 234
– obwodowe, zakres unerwienia 265
– odwodzący 80, 248, 255
– okoruchowy 79, 248, 255
– podjęzykowy 254, 257
– przedsionkowo-ślimakowy 252, 256
– przedsionkowy, uszkodzenie 252
– słuchowy, uszkodzenie 252
– trójdzielny 249, 255
– – badanie funkcji, czuciowych 250
– – – ruchowych 249
– twarzowy 251, 256
– – badanie funkcji ruchowych i czuciowych 251
– węchowy 247, 255
– wzrokowy 248, 255
Neuralgia nerwu kulszowego 234
Neuron ruchowy, obwodowy 258
– ośrodkowy 257
NIC 354
Niedowład 260
Niemiarowość, oddechowa patologiczna 303
– tętna 138
Niezstąpienie jądra 193
NOC 352
Nos 124
– badanie 86
– – dokumentowanie wyników 89
– charakterystyka wydzieliny 89
– drożność 116, 126
– zmiany na błonie śluzowej 89
Noworodek, ocena w skali Apgar 285

Objaw(y), Argylla Robertsona 83
– Barlowa 292
– Brudzińskiego 280
– Chadwicka 174
– chełbotania, badanie 188
– Heagara 174
– Hermana 281
– Kerniga 281
– koła zębatego 260
– oponowe, badanie 280
– – – dokumentowanie wyników 281
– Ortolaniego 292
– piłeczki pingpongowej 293
– rury ołowianej 260
– scyzorykowy 260
– szyi łabędziej 233
– zwichnięcia stawu biodrowego u niemowlęcia 292
Obmacywanie 41
Obojnactwo 307
Obrzęk(i) 61
– badanie 59
– stawu, kolanowego 235
– – skokowego 235
Obrzmienie moszny, badanie 188, 189
Obwód(ody), głowy dziecka, pomiar 292
– goleni, pomiar 200
– kończyny, dolnej 200
– – górnej 200
– ramienia, pomiar 47
Oczopląs 252
Odbyt 163
– badanie 163, 189
– – dokumentowanie wyników 165
– – palpacyjne 164, 189, 194
– oglądanie 164
– opis okolicy za pomocą położenia wskazówek zegara 164
Odbytnica 163
– polip 194
– rak 194
Oddech(y) 48
– Biota 125

Oddech(y), Cheyne'a-Stokesa 125
– częstość 48
– – u osób w wieku geriatrycznym 319
– Kussmaula 125
– liczba u dziecka 298, 299
– ocena 116, 125
– pomiar 48
– – dokumentowanie wyników badań 49
Oddychanie, jakość 48
– ocena toru 116
– płucne 113
– przyspieszone 125
– tkankowe 113
– tor 300
– wewnętrzne 113
– zewnętrzne 113
– zwolnione 125
Odgłos(y) opukowy(e) 119, 126
– bębenkowy 156, 305
– rodzaje 41
Odma opłucnowa 302
Odnoga pachowa 106
Odruch(y) 272
– Babińskiego 312, 278, 279
– badanie 272
– – dokumentowanie wyników 279, 280
– brak 278
– brzuszne 278
– Chaddocka 279
– chwytania 310
– fizjologiczne 309, 310
– gardłowy 92, 253
– głęboki(e) 272, 274
– kolanowy 274, 276
– – wzmocnienie 277
– Moro 310
– na nastawność 77
– Oppenheima 279
– podeszwowy 278, 279, 310
– powierzchowne 274
– rogówkowy 250, 251
– Rossolimo 279
– rzepkowy 274
– skokowy 274, 277
– ssania 310
– szukania 310

Odruch(y), ścięgniste głębokie 273
– z mięśnia, dwugłowego 274, 275
– – ramienno-promieniowego 274
– – trójgłowego 274, 276
– ze ścięgna Achillesa 274
– zniesienie 278
Oglądanie 40
– gruczołów piersiowych 108
– języczka 253
– języka 254
– klatki piersiowej 115
– łechtaczki 172
– mięśni żucia 249
– oczu 248
– odbytu 164
– skóry 58
– ujścia cewki moczowej 174
– warg sromowych 172
– węzłów chłonnych 69
– – pachwinowych 188
Ogon gruczołu piersiowego 106
Oko(czy), akomodacja 249
– oglądanie 248
OLDCART 26, 27
OODA 335
Opieka pielęgniarska, dokumentowanie 332
Opryszczka narządów płciowych 179, 191
Opukiwanie 41
– brzucha, techniki 156
– klatki piersiowej 119
– pęcherza moczowego 156
– powierzchni brzucha 157
– śledziony 156
– technika 41, 42
– wątroby 156, 157
Orientacja 240
– przestrzenna 244
Osłabienie napięcia mięśniowego 260
Osłuchiwanie 43
– aorty brzusznej 155
– brzucha 155
– płuc 121
– serca 134
– – u dziecka 301
Osłuchiwanie, śledziony 155
– tętnicy nerkowej 155
– wątroby 155
Osoba(y), dorosła, ocena stanu zdrowia 340
– w wieku geriatrycznym, badanie, czucia dotyku 323
– – – głowy 320
– – – gruczołu(ów), krokowego 328
– – – – piersiowych 324
– – – jamy, brzusznej 326
– – – – ustnej 316
– – – klatki piersiowej 324
– – – narządów płciowych, męskich 328
– – – – żeńskich 325
– – – narządu, słuchu 317, 323
– – – – wzroku 317, 321
– – – okolicy pachowej 324
– – – płuc 324
– – – podmiotowe 311, 312
– – – przedmiotowe 311, 317
– – – skóry 320
– – – szyi 320
– – – tętna 326
– – – układu, mięśniowo-szkieletowego 328
– – – – nerwowego 328
– – – – sercowo-naczyniowego 324
– – ból 316
– – choroby przewlekłe i przebyte 314
– – ciśnienie krwi tętnicze 319
– – częstość oddechów 319
– – dolegliwości 314
– – nastrój 316
– – ocena stanu zdrowia 346
– – pytania standardowe 316
– – równowaga 317
– – rytm i częstość serca 319
– – smak 323
– – stan odżywienia 316
– – temperatura 319
Osoba(y), w wieku geriatrycznym, upadki 317
– – węch 323
– – wywiad 316
– – – dotyczący leków 314
– – – rodzinny 315
– – – socjalny 315
– – zwieracze 317
Ostrość widzenia, badanie 78
Ośrodek mowy, czuciowy 237
– ruchowy 237
Otoczka brodawki sutkowej 106
Otwór klatki piersiowej, dolny 102
– górny 102
– – wymiar, poprzeczny 103
– – – strzałkowy 103
Owłosienie 62
– u osób w wieku geriatrycznym 322
Owrzodzenie(a) 61
– opryszczkowe 94
– prącia 191

Pacjent, nieprzytomny 25, 29
– w stanie termalnym 25
Palec(ce), badanie 219
– butonierkowaty 233
– deformacja 236
– zakres ruchu 203, 221
Palpacja 41
Paluch, badanie 229
– deformacja 236
– zakres ruchu w stawach 204
Pamięć 242
– długoterminowa 242
– krótkoterminowa 242
– upośledzenie 24
Parafrazowanie 23
Parametry życiowe podstawowe 48
Paznokieć(cie) 57
– badanie 63
– brak 65
– budowa 63, 64
– – dokumentowanie wyników 64, 65

Paznokieć(cie), u osób w wieku geriatrycznym 322
– zmiany, postaci 65
– – zabarwienia 65
Pęcherz moczowy, opukiwanie 156
Pęcherzyki nasienne 184
Piegi 61
Pielęgniarka praktyki zaawansowanej 352
Plamy, barwnikowe 61
– naczyniowe 61
Płaskostopie 293
– fizjologiczne 293
Płaszczyzny ciała 37
Płat ciemieniowy, funkcje 268
Płeć 20
Płuca 113
– badanie u osób w wieku geriatrycznym 324
– granica(e) dolna(e) 121, 126
– – ruchomość 120, 126
– – u dziecka 299
– osłuchiwanie 121
Płyn, w jamie opłucnej 302
– w osierdziu 302
Płytka paznokci, wgłębienie 65
Pobyty w szpitalu 30
Pochewka ścięgnista, zapalenie 233
Pochwa 168
– infekcja 307
Pochylenie w bok 210
Podniebienie twarde 296
Pola, osłuchiwania zastawek serca 132
– słuchowe 237
Polip, odbytnicy 194
– wewnątrzszyjkowy 181
Polipragmazja 316
Połykanie, badanie zdolności 253
Pomiar, C7–S1 210
– ciśnienia, krwi tętniczego 50
– – – błędy najczęstsze 53
– – – dokumentowanie wyników badań 54
– – – etapy 53
Pomiar, ciśnienia, żylnego 145
– części ciała poszczególnych 45
– długości kończyn(y), górnych 46
– – dolnej względny 201
– grubości fałdu skórno-tłuszczowego 46, 47
– masy ciała 46
– – dokumentowanie wyników badań 47
– – dziecka 285, 287
– obwodu, głowy dziecka 292
– – goleni 200
– – ramienia 47
– oddechów 48
– – dokumentowanie wyników badań 49
– Schobera 210
– temperatury ciała 54
– – dokumentowanie wyników badań 55
– – pod pachą 55
– tętna 49
– – dokumentowanie wyników badań 50
– – patrz też Badanie tętna
– wzrostu 46
– – dziecka 287
– zakresu ruchu stawu łokciowego 204
Porażenie 260
Porost włosów, nadmierny 63
– zmiany 63
Poród, ustalanie daty 174
Postawa ciała pionowa 286
Powieki 75, 296
Powrózek nasienny, badanie 187
– wodniak 193
– żylaki 193
Pozycja ciała 44
– anatomiczna ustalona 35, 36
– siedząca przyjmowana 44
– stojąca, ocena sylwetki 198
Praksja 241
Prącie 183
– badanie 187
Prącie, owrzodzenia 191
– rak 192
– zmiany 191
Procesy, emocjonalno-motywacyjne 239, 244
– orientacyjno-poznawcze 239, 240
Proporcje ciała 45
Prostowanie 210
Próba(y), Barrego 260
– „nos–palec badającego” 271
– oka zakrytego 80
– „palec do nosa” 271
– „pięta–kolano–goleń” 271
– Rinnego 85, 86
– Romberga 252, 256
– słuchowe 84
– szeptu 84
– Webera 84, 85, 86
– zakrywania-odkrywania 80
Przeczosy 61
Przedramię, badanie 216
– zakres ruchu w stawach 202
Przedsionek(ki), jamy ustnej 90
– serca 131
Przekwitanie 169
Przepuklina 189
– mosznowa 193
– odbytnicy 180
– pachwinowa skośna 194
– pęcherzowo-cewkowa 180
– udowa 194
Przerost, gruczołu krokowego łagodny 194
– łechtaczki 307
Przestrzeń osobista 19
Przewodzenie głosu 122, 127
Przodopochylenie miednicy nadmierne 233
Przydatki skóry, badanie 57
– – u dziecka 289
Przyjaciele 25
Przyjmowanie leków 28
– regularność 29
Przykurcz, Dupuytrena 233
– stawu łokciowego 232

Przyusznica 94
Przyzwyczajenia żywieniowe 28
Pytania, otwarte 23
– wyjaśniające (sondujące) 23
– zamknięte 23

Rak, gruczołu krokowego 194
– odbytnicy 194
– prącia 192
– sromu 179
– szyjki macicy 181
Ramię, pomiar obwodu 47
Rasa 21
Rdzeń kręgowy 237
– sznury tylne 263
Receptory czuciowe 262
Refleksja 23
Reguła Naegelego 174
Religia 18
Ręka, badanie 218
– ocena ukrwienia tętniczego 142
– zmiany w jej obrębie 233
Rodzina 17, 25
Rogówka 75
– odbicie światła 248
Rozejście spojenia łonowego 233
Rozmowa z pacjentem, przebieg 239
Rozpadlina 61
Rozszerzalność klatki piersiowej 118, 126
Równowaga, badanie 270
– – dokumentowanie wyników 272
– – u osób w wieku geriatrycznym 317
Różaniec pokrzywiczy 298
Różnorodność kulturowa 16
RR 50
Ruchomość skóry 59
Ruchy, ciała 286
– czynne, badanie 260
– mimowolne 259
– naprzemienne 271
– obrotowe 210
Rzadkoskurcz 303
Rzężenia 127
– wilgotne 127

Samoopieka, deficyt 282
Serce 129
– badanie 130
– – przedmiotowe, dokumentowanie wyników 146
– budowa wewnętrzna 131
– cykl pracy 131
– częstość pracy u dziecka 303
– czynność 147
– faza, rozkurczu 132
– – skurczu 131
– miarowość 147
– osłuchiwanie 134
– – u dziecka 301
– położenie w klatce piersiowej 130
– rytm i częstość u osób w wieku geriatrycznym 319
– ułożenie prawostronne 302
SF-MPQ 343
Siatkówka 76
Siła, mięśni(a), czworobocznego 254
– – języka 254
– – mostkowo-obojczykowo-sutkowego 254
– mięśniowa, badanie 260, 261
– – klasyfikacja 261
– – ocena 254
Skala(e), Apgar 285, 286, 337, 338
– Barthel 346, 347
– bezsenności ateńska 342, 345
– depresji geriatryczna 347, 349
– FLACC 338, 340
– klinimetryczne 336
– Lovetta 261
– Tannera 170
– – stadia rozwoju włosów łonowych 170, 171
Skala(e), Tannera, stopień rozwoju, cech płciowych męskich 186, 187
– – – gruczołu piersiowego 171, 172
Sklepienie, podłużne 229
– poprzeczne 229
Skolioza 105, 231, 293
Skóra, badanie 57
– – dokumentowanie wyników 60
– – palpacyjne 59
– – u dziecka 287
– – – dokumentowanie wyników 288
– – u osób w wieku geriatrycznym 320
– budowa 57
– ciepłota 59
– elastyczność 59
– głowy, zmiany 75
– grubość 58
– kolor 58
– napięcie 59
– oglądanie 58
– powierzchnia 58
– ruchomość 59
– wilgotność 59
– właściwa 57
– zabarwienie 58
– – zmiany 60
Skręt jądra 193
Skurcze serca, częstość 147
Słuch, badanie 84
Smak u osób w wieku geriatrycznym 323
SOAP 333
SOAPIE 335
SOAPIER 335
Spastyczność 260
Splątanie przewlekłe 282
Spodziectwo 191, 192, 307
Spojenie łonowe, rozejście 233
Spojówka(i) 75, 294
Spożywanie posiłków 282
Sprawność intelektualna, upośledzenie 316
SQAP 352
Srom 167
– rak 179
Stan, dynamiczny 199

Stan, odżywienia 45
– – dziecka 287
– – ocena 46
– – u osób w wieku geriatrycznym 316
– psychiczny, ocena 239, 245
– – – dokumentowanie wyników badania 245
– – skala oceny krótka 246
– termalny 25
– zdrowia, aktualny 28
– – ocena 15, 336
– – – na podstawie wyników badań 331
– – – schemat opisu 333
– – – wstępna, formułowanie 282
– – – u dziecka 337
– – – – ogólna 284
– – – u osoby, dorosłej 340
– – – – w wieku geriatrycznym 346
Starzenie się 311
Staw(y), barkowy 213
– – zakres ruchu 214, 215
– – zmiany w jego obrębie 232
– biodrowo-krzyżowe, ocena 213
– – badanie 223
– – zakres ruchu 203, 223–225
– – zmiany w jego obrębie 234
– – zwichnięcie u niemowlęcia, objawy 292
– kolanowy, badanie 226
– – obrzęk 235
– – przykurcz 234
– – zaburzenia osi 234
– – zakres ruchu 203, 227
– – – ograniczenie 234
– – zmiany w jego obrębie 234
– łokciowy, badanie 216
– – przykurcz 232
– – zakres ruchu 216
– – – pomiar 204
– – zmiany w jego obrębie 232
Staw(y), ramienny, zwichnięcie 232
– skokowy, badanie 227
– – obrzęk 235
– – zakres ruchu 204
– – zmiany w jego obrębie 235
– skroniowo-żuchwowy, badanie 206
– – zmiany 230
– śródręczno-paliczkowe, zakres ruchu 220
– zakres ruchu 202
Stenoza aortalna 325
Stereognozja 268
Stłumienie, przeponowe 120
– serca, bezwzględne 133
– – względne 133, 146
– – – granice 134
– wątrobowe 161
– znad śledziony 161
Stopa, badanie 227
– deformacje 235
– końsko-szpotawa 291
– zakres ruchu 204, 228
Strefa dystansu osobista 19
Strup 61
Stulejka 191
Stwardnienie zastawki aortalnej 325
Sylwetka w pozycji stojącej, ocena 198
Symetria klatki piersiowej 124
System, AMPLE 27
– Calgary–Cambridge 26
– OLDCART 26, 27
Sytuacja, rodzinna 32
– socjalna 32
Szmer(y), jelitowe 161
– oddechowy(e), dodatkowe 127
– – oskrzelowy 122, 123, 127
– – pęcherzykowy 122, 123, 127
– – – u dziecka 300
– przygodne 303
Sznury rdzenia kręgowego tylne 263
Szpotawość, miara 226
Sztywność 260
– karku, badanie 280
Szyja, badanie 73
– – u dziecka 292
– – u osób w wieku geriatrycznym 320
– okolice topograficzne 73
– struktury 95
– – badanie 94
Szyjka macicy, nieprawidłowości 181
– zmiany 181

Śledziona 305
– opukiwanie 156
– osłuchiwanie 155
Ślinianka(i) 296
– przyuszna, badanie 94
– ujścia 90
Śluz szyjkowy fizjologiczny 179
Świsty 127

Tablice Ishihary 78
Tarcie opłucnowe 127
Tarczyca 95
– badanie u dziecka 297
Tchawica, badanie 98
– – palpacyjne 118
– położenie 117
Temperatura, badanie czucia 267
– ciała 48
– – pomiar 54
– – – dokumentowanie wyników badań 55
– – – pod pachą 55
– – – u osób w wieku geriatrycznym 319
Termometry 55
Test, Allena 142, 148
– Ishihary 78
Tęczówka 76
Tętnica(e) 129
– główne 138
– grzbietowa stopy, badanie tętna 139, 142
– nerkowa, osłuchiwanie 55
– piszczelowa tylna, badanie tętna 139

Tętnica(e), podkolanowa, badanie tętna 139, 141
– promieniowa, badanie tętna 139, 140
– ramienna, badanie tętna 139, 141
– szyjna, badanie tętna 139, 141
– – różnicowanie tętnienia żylnego i tętna 145
– udowa, badanie tętna 139, 141
Tętno 48, 137, 148
– badanie, miejsca pomiaru 140
– – na tętnicy, grzbietowej stopy 139, 142
– – – piszczelowej 139
– – – podkolanowej 139, 141
– – – promieniowej 139, 140
– – – ramiennej 139, 141
– – – szyjnej 139, 141
– – – udowej 139, 141
– – u osób w wieku geriatrycznym 326
– chybkość 139
– częstość 137
– miarowość 138
– napięcie 138
– niemiarowość 138
– pomiar 49
– – dokumentowanie wyników badań 50
– prawidłowe 49
– tętnicze, badanie 137
– u dziecka 301
– wypełnienie 138
– żylne 149
– – a tętno na tętnicy szyjnej 145
– – badanie 143
Ton(y) serca 147
– cechy prawidłowe 136
– czwarty 147
– drugi 132, 135
– pierwszy 132, 135
– trzeci 137, 147
– miejsca osłuchiwania 135
– rozróżnianie 136
Ton(y) serca, schemat osłuchiwania 135
Tor oddychania 116, 298
– brzuszny 116
– piersiowy 116
Torbiel najądrza 193
Torbielki łojowe 193
Tożsamość kulturowa 16
Transiluminacja 188
Trzeszczenia 127
Trzustka 307
Tułów, pomiar długości 45
– proporcje 288
Twardówka 75
Twarz, wygląd 75
– zmiany 75
Twarzoczaszka 73
Typ, asteniczny 45
– atletyczny 45
– konstytucyjny 287
– pykniczny 45

Ubieranie się 45, 282
Ucho, badanie 83
– – dokumentowanie wyników 86
– środkowe 83
– zewnętrzne 83
– – badanie 84
Uczulenia na leki/inne substancje 29
Uderzenie koniuszkowe 130, 146
– miejsce wyczuwania 133
– ocena 132
Ujście, aorty 131
– cewki moczowej, oglądanie i badanie palpacyjne 174
– – zmiany 180
– kanału szyjki macicy zewnętrzne 178
– pnia płucnego 131
– przedsionkowo-komorowe 131
Układ(y), dolegliwości z ich strony 30
– kostno-stawowy, badanie u dziecka, dokumentowanie wyników 291
– krążenia, badanie 129
Układ(y), krążenia, u dziecka 302
– – – – dokumentowanie wyników 302
– – objawy dysfunkcji najczęstsze 31
– mięśniowo-szkieletowy, badanie 197, 205
– – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– narządu ruchu, badanie 197
– – – dokumentowanie wyników 230
– – stan, miejscowy 201
– – – odcinkowy 200
– – – ogólny 197
– nerwowy, badanie, u dziecka 307
– – – – dokumentowanie wyników 309
– – – u osób w wieku geriatrycznym 328
– – objawy dysfunkcji najczęstsze 31
– – ośrodkowy 237
– oddechowy, badanie 113
– – – dokumentowanie wyników 124
– – – u dziecka 297
– – – – dokumentowanie wyników 298
– – część oddechowa 113
– – objawy dysfunkcji najczęstsze 31
– – zarys 113
– płciowy, męski, budowa 183
– – żeński, budowa 167
– pokarmowy, objawy dysfunkcji najczęstsze 31
– pozapiramidowy 258
– ruchu, badanie 257
– – – dokumentowanie wyników 262
– sercowo-naczyniowy, badanie u osób w wieku geriatrycznym 324
– żylny, badanie 143
Ukrwienie tętnicze ręki, ocena 142
Ułożenie ciała, fizjologiczne 309

Ułożenie ciała, niemowlęcia nieprawidłowe 310
– pośrednie 309
– w łóżku 44
Upadki, ryzyko 282
– u osób w wieku geriatrycznym 317
Upośledzenie, pamięci 24
– sprawności intelektualnej 316
Uwaga 242
Uwarunkowania, kulturowe 15
– społeczne 15
– spowodowane, płcią 20
– – rasą 20
– – wiekiem 20
Uzależnienie od, alkoholu 25
– narkotyków 25

Wargi 298
– sromowe, mniejsze, oglądanie i badanie palpacyjne 172
– – większe, oglądanie i badanie palpacyjne 172
– – zmiany w ich obrębie 179
Wątroba 307
– badanie palpacyjne 158, 159, 162
– opukiwanie 156, 157
– osłuchiwanie 155
Wejście do pochwy, badanie 174
– zmiany 179
Węch u osób w wieku geriatrycznym 323
Węzły chłonne (limfatyczne), badanie 57, 66
– – dokumentowanie wyników 71
– – palpacyjne 69
– – u dziecka 291
– – – dokumentowanie wyników 290
– głowy 66
– – badanie 69
– – rozmieszczenie 66
– kończyn dolnych 67
Węzły chłonne (limfatyczne), nadobojczykowe, badanie 70
– oglądanie 69
– pachowe, badanie 111
– pachwinowe, badanie 70
– – oglądanie i badanie palpacyjne 188
– podkolanowe, badanie 71
– ramienia 67, 68
– – badanie 70
– ręki 67
– szyi 66
– – badanie 69
– – rozmieszczenie 66
– – zlewiska 67
– wielkość prawidłowa 71
– zlewiska 68
– zmiany 71
Widzenie, badanie, ostrości 78
– – pola 78, 79
– barw, badanie 78
– z bliska, badanie 78
– z dali, badanie 78
Wiek 21, 24
Wierzchniactwo 307
Wilgotność skóry 59
Wirus, brodawczaka ludzkiego 192
– opryszczki 191
Włosy 57
– badanie 62
– – dokumentowanie wyników 62, 63
– dziecka, rozmieszczenie 291
– łonowe, stadia rozwoju według skali Tannera 170, 171
– porost, zmiany 63
– wypadanie 63
– zmiany 75
Wnętrostwo 193
WOBr 341
Wodniak, jądra 307
– powrózka nasiennego 193
Wodogłowie 293
Wrażenie(a), czuciowe 237
– pierwsze 44
– wzrokowe 237
Wrzód weneryczny 179
Wskaźnik masy ciała 47
Wybroczyny skórne 61
Wydzielina z nosa, charakterystyka 89
Wygląd 239
– twarzy 75
– zewnętrzny 44
Wymiar(y), klatki piersiowej, określanie 115
– – poprzeczny 115
– – przednio-tylny 115
– otworu klatki piersiowej górnego, poprzeczny 103
– – strzałkowaty 103
Wyniki badania(ń), brzucha, dokumentowanie 160
– ciśnienia krwi tętniczego, dokumentowanie 54
– czucia, dokumentowanie 270
– dokumentowanie 44
– dziecka, dokumentowanie 286
– gardła, dokumentowanie 93
– – dziecka, dokumentowanie 296
– głowy dziecka, dokumentowanie 293
– gruczołu(ów, piersiowych, dokumentowanie 112
– – tarczowego, dokumentowanie 97
– jamy, brzusznej u dziecka, dokumentowanie 305
– – ustnej, dokumentowanie 93, 94
– – – u dziecka, dokumentowanie 296
– koordynacji ruchowej, dokumentowanie 272
– masy ciała, dokumentowanie 47
– narządu(ów), moczowo-płciowych u dziecka, dokumentowanie 307
– – płciowych, męskich, dokumentowanie 191

Wyniki badania(ń), narządu(ów), żeńskich, dokumentowanie 179
– – słuchu u dziecka, dokumentowanie 295
– – węchu i zatok przynosowych u dziecka, dokumentowanie 295
– – wzroku, dokumentowanie 82, 83
– nerwów czaszkowych, dokumentowanie 255
– nosa, dokumentowanie 89
– objawów oponowych, dokumentowanie 281
– ocena stanu zdrowia pacjenta na ich podstawie 331
– odbytu, dokumentowanie 165
– oddechu, dokumentowanie 49
– odruchów, dokumentowanie 279, 280
– paznokci, dokumentowanie 64, 65
– podmiotowego 282
– – analiza na potrzeby oceny stanu zdrowia 352
– – dokumentowanie 332
– przedmiotowego 282
– – analiza na potrzeby oceny stanu zdrowia 352
– – dokumentowanie 332
– równowagi, dokumentowanie 272
– serca, dokumentowanie 146
– skóry, dokumentowanie 60
– – i jej przydatków u dziecka, dokumentowanie 288
– stanu psychicznego, dokumentowanie 245
– temperatury ciała, dokumentowanie 54
– tętna, dokumentowanie 50
– ucha, dokumentowanie 86
Wyniki badania(ń), układu, kostno-stawowego u dziecka, dokumentowanie 291
– – krążenia u dziecka, dokumentowanie 302
– – narządu ruchu, dokumentowanie 230
– – nerwowego u dziecka, dokumentowanie 309
– – oddechowego, dokumentowanie 124
– – – u dziecka, dokumentowanie 298
– – ruchu, dokumentowanie 262
– węzłów chłonnych, dokumentowanie 71
– – u dziecka, dokumentowanie 292
– włosów, dokumentowanie 62, 63
– zatok przynosowych, dokumentowanie 89
Wypadanie włosów 63
Wypełnienie tętna 138
Wypuk bębenkowy 161
Wyraz twarzy 44
Wyrostek pachowy 106
Wyrośla kostne 234
Wysokość głowy, pomiar 45
Wytrysk nasienia 184
Wywiad 23
– dotyczący, dolegliwości ze strony narządów i układów 30
– – leków u osób w wieku geriatrycznym 314
– – stanu zdrowia aktualnego 28
– pediatryczny 283
– rodzinny 32
– – u osób w wieku geriatrycznym 315
– socjalny 32
– – u osób w wieku geriatrycznym 315
– środowiskowy 32
– z osobami w wieku geriatrycznym 316
Wziernik pochwowy 176
Wziernik pochwowy, etapy zakładania 176, 177
Wzrost, pomiar 45, 46
– – u dziecka 285

Zabarwienie skóry 58
– zmiany 60
Zabiegi operacyjne 30
Zaburzenia psychiczne 44
Zachłyśnięcie, ryzyko 282
Zachowanie 239
Zadzierzgnięcie napletka 191
Zanik jąder 193
Zanokcica 65
Zapalenie, cewki moczowej 192
– gardła, ostre 93
– – przewlekłe 93
– gruczołu krokowego ostre 194
– jądra ostre 193
– kaletki, krętarzowej 234
– – wyrostka łokciowego 232
– najądrza, gruźlicze 193
– – ostre 193
– napletka 191
– pochewki ścięgnistej 233
– pochwy, grzybicze 179
– – rzęsistkowe 179
– – zanikowe 179
– ścięgna odwodziciela długiego kciuka 232
– żołędzi 191
Zapłodnienie 184
Zastawka(i), aorty 131, 132
– dwudzielna (mitralna) 131, 132
– – zwężenie 305
– pnia płucnego 131, 132
– przedsionkowo-komorowe 131
– serca, pola (miejsca) osłuchiwania 132
– trójdzielna 131, 132
– żylne 131
Zatoka(i), przynosowe, badanie 86, 88
– – – dokumentowanie wyników 89

Zatoka(i), przynosowe, u dziecka 296
– – – – dokumentowanie wyników 297
– – położenie 88
– wieńcowa 131
Zborność, badanie 270
Zdrowie, ocena stanu 15
Zespół, Adiego 83
– Hornera 83
– kanału, Guyona 233
– – nadgarstka 233
– Klinefeltera 193
– nerczycowy 309
Zespół rowka nerwu łokciowego 232
Zęby mleczne 298
Złamanie kości promieniowej 232
Zmiany skórne 59, 61
Zwichnięcie stawu biodrowego, objawy u niemowlęcia 294
Zwieracze u osób w wieku geriatrycznym 319

Źrenice 296
– badanie, akomodacji 77
Źrenice, badanie, dokumentowanie wyników 83
– – reakcji na światło 77
– zaburzenia niezwiązane z narządem wzroku 83

Żołądź, zapalenie 191
Żylaki powrózka nasiennego 193
Żyły, główne 131, 144
– płucne 131
– szyjne, ciśnienie 143
– – tętnienie 143

Ocena stanu pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego to podstawowe kwalifikacje absolwenta kierunku pielęgniarstwo, a jednocześnie pierwszy i kluczowy etap procesu opieki.

W każdym rozdziale publikacji uwzględniono elementarne zagadnienia dotyczące anatomii, zasad i sposobu badania oraz dokumentację wyników w ujęciu tabelarycznym. W dokumentacji wyników badania podmiotowego i przedmiotowego na tle cech prawidłowych uwzględniono objawy chorobowe w obrębie układu czy narządu. Poszczególne techniki badań zostały dokładnie zilustrowane.

Nowe wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o 2 nowe rozdziały: jeden z nich dotyczy odrębności badania podmiotowego i przedmiotowego osoby w wieku geriatrycznym, drugi – jak uzyskane wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego dokumentować i zastosować do oceny sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek i położnych, a także w codziennej praktyce.

PZWL

PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o.
Infolinia: 801 33 33 88
www.pzwl.pl
www.nursing.com.pl

ISBN 978-83-200-6007-2
9 788320 060072